



醫@Easy

僅供參考

V22_2025



AIA.COM.HK

免責聲明

編制此健康核保指引之目的是希望加強各位對一般核保常見的疾病之認識，從而為客戶提供更佳的建議及服務。

此指引內的資料只供參考之用。公司仍會根據個別客人的健康狀況，在有需要的情況下要求客人提供額外之健康資料或進行額外之身體檢查。此指引之核保要求將適用於每一個以下列出的產品，但核保結果將因產品而異及根據理賠經驗而不時修訂。在健康核保指引中未列出的情況，會作個別考慮。如有任何差異，本公司核保部將有所保留作出最終決定。

驗身 / 化驗小提示:

1. 驗身期間，客人需要脫去衣服以進行身體檢查(乳房，胸部及腹部)。
2. 如果客人具有相關的病史，在客戶同意下，可能需要進行生殖器官檢查。
3. 客人在體檢報告上的簽署應與申請書上的簽署一致。
4. 客人驗身時必須進行尿液檢查。
5. 建議女性客人在經期後7天進行驗身或尿液檢查。
6. 驗血類別BPA，BPI，BPM，BPN，BPP及BPR在驗血前，必須空腹至少6小時。
7. 驗血類別BPA，BPD，BPI，BPP及BPR在驗血前，建議在三日內不要飲酒。

產品及其保障對照一覽表 (自2025年3月)



保障	產品
人壽	• 「裕滿人生」保障計劃2 • 「充裕未來」計劃 2 (特級保障) • 守康易定期壽險計劃 • 泰然安心保2 • 尊誠定期壽險計劃 (及附加契約) • 多重安心保2 • 多重智倍保 • 愛伴航 • 愛伴航 - 首護摯寶* • 進泰安心保2 • 樂怡人生 • 卓智投資計劃 2 • 卓達智悅 2 • 卓耀明珠 2 • 「您想」投資連繫壽險計劃 • 摯誠定期壽險計劃 (及附加契約) • 進添計劃癌症保障 (及明珠版) • 智護癌症保* • 簡護危疾保 (包括明珠版及附加契約) • AIA 唯一摯保 - 全面保障 • AIA 「兩全保」保障型投資相連壽險計劃 (整付保費) • 「自在自選」危疾保

備註：*核保結果只接受標準評級或拒絕受保；不會有不保事項及附加保費

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

產品及其保障對照一覽表 (自2025年3月)



保障	產品
危疾	• 特級付款人保障連危疾附加契約 • 危疾附加契約 • 特級危疾豁免繳付保費附加契約 • 守康易危疾保 • 特選危疾附加契約 • 泰然安心保2 • 多重安心保2 • 愛伴航 • 愛伴航 - 首護摯寶 • 進泰安心保2 • 多重智倍保 • 進升危疾保障計劃 • 「進添」計劃 - 癌症保障 (及明珠版) • 智護癌症保 • 嚴重疾病醫療保障附加契約 (及明珠版) • 簡護危疾保 (包括明珠版及附加契約) • AIA 唯一摯保 - 全面保障 • 「自在自選」危疾保 • 「友愛護」癌症保障計劃

備註：*核保結果只接受標準評級或拒絕受保；不會有不保事項及附加保費

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

產品及其保障對照一覽表 (自2025年3月)



保障	產品
早期危疾	• 多重安心保2 • 愛伴航 • 進泰安心保2 • 多重智倍保 • 智護癌症保* • 嚴重疾病醫療保障附加契約 (及明珠版) • 簡護危疾保 (包括明珠版及附加契約) • AIA 唯一摯保 - 全面保障 • 「自在自選」危疾保
住院	• 至尊醫療系列 • 特級「健康之寶」系列 • 「倍無憂」醫療保障計劃 (只適用於澳門) • 「永無憂」住院及手術賠償附加契約 (只適用於澳門) • 「樂無憂」住院惠益附加契約 • 靈活住院惠益保障計劃 • 保費回贈 - 住院入息保障 • 「常伴您」保費退還住院現金保障 • 自選人身意外保險2 - 住院入息保障 • AIA自願醫保計劃系列 • 「尊耀明珠」醫療計劃 (及附加契約) • 「尊耀」醫療計劃及附加契約 (只適用於澳門)
癌症全方位	• 癌症全方位系列 • 全程守護健康保 • 全程守護健康保附加契約 • 「友愛護」癌症保障計劃
AIA 唯一摯保 (AOACS)	AIA 唯一摯保 - 癌症及嚴重傳染病保障系列AOACS

備註：*核保結果只接受標準評級或拒絕受保；不會有不保事項及附加保費

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

疾病

1. 哮喘·····	P.11
2. 孤獨性障礙·····	P.17
3. 良性前列腺增生症·····	P.21
4. 乳房疾病·····	P.24
5. 支氣管炎·····	P.31
6. 癌症·····	P.36
7. 腦血管疾病·····	P.40
• 中風	
• 短暫性腦缺血發作 (TIA)	
8. 冠狀動脈性心臟病 (CAD)·····	P.45
9. 2019冠狀病毒病·····	P.50
10. 糖尿病 (DM)·····	P.53
11. 濕疹/ 皮炎·····	P.57
12. 眼疾·····	P.60
• 白內障	
• 青光眼	
• 視網膜脫落	
13. 結腸直腸癌 / 乳癌 / 其它癌症之家族病史·····	P.68

14. 糖尿病之家族病史	P.77
15. 柏金遜症之家族病史	P.81
16. 脂肪肝	P.84
17. 女性生殖器官疾病	P.87
• 子宮頸上皮細胞瘤樣增生 (CIN)	
• 卵巢囊腫	
• 子宮纖維瘤	
• 多囊性卵巢症	
18. 膽囊疾病	P.102
• 膽囊息肉	
• 膽石	
19. 腸胃道疾病	P.108
• 胃炎	
• 消化性潰瘍	
• 胃食道反流 (GERD)	
20. 妊娠糖尿病	P.117
21. 血尿症	P.120

22. 肝炎.....	P.126
• 甲型肝炎	
• 乙型肝炎	
23. 高膽固醇血症 / 高三酸甘油酯血症.....	P.133
24. 高血壓.....	P.139
25. 高尿酸血症（痛風）.....	P.143
26. 腸道疾病.....	P.146
• 結腸息肉	
• 痔瘡	
27. 川崎病.....	P.154
28. 精神障礙.....	P.159
• 抑鬱症	
• 焦慮症	
29. 新生兒黃疸.....	P.169
30. 非瓣膜性心臟疾病.....	P.172
• 心房間隔缺損 (ASD)	
• 心室間隔缺損 (VSD)	
31. 睡眠窒息症(OSA)	P.182

32. 中耳炎·····	P.186
33. 過重·····	P.190
34. 垂體疾病·····	P.194
• 泌乳素瘤	
• 高催乳素血症	
35. 早產兒·····	P.199
36. 蛋白尿症·····	P.204
37. 前列腺特異抗原(PSA)異常·····	P.208
38. 肺結節·····	P.215
39. 腎石·····	P.230
40. 類風濕關節炎·····	P.235
41. 脊椎彎曲·····	P.241
42. 地中海貧血·····	P.246
43. 甲狀腺疾病·····	P.251
• 甲狀腺功能亢進症	
• 甲狀腺功能減退症	
• 甲狀腺結節	

附錄

甲. 乳房超聲波報告的首選化驗所·····	P.258
乙. 盆腔超聲波報告的首選化驗所·····	P.259
丙. 前列腺超聲波報告的首選化驗所·····	P.260

常見疾病及檢查詞彙表

1. 驗血類別·····	P.261
2. 常見疾病·····	P.266
3. 常見檢查·····	P.282

<u>數位等級表</u> ·····	P.284
--------------------	-------

哮喘

簡介：這種情況是由於肺部的氣道炎症，影響氣道內神經末梢的敏感性，使它們變得容易過敏

徵狀：哮喘病徵包括呼吸困難、咳嗽、胸悶及喘鳴

哮喘



成因

- 遺傳性疾病；吸煙；外在環境因素

治療

- 吸入性藥物
- 根據嚴重程度使用口服藥物

風險分類

風險因素	輕度	中度	嚴重
症狀的頻率	每週多於兩天	每天	持續一整天
因此病而不能工作	沒有	每年等於或少於兩個星期	每年多於兩個星期
住院	沒有	有	有
對治療的反應	對低劑量吸入性藥物 有良好反應	每天需使用高劑量吸入性 藥物及/或口服藥物	對高劑量吸入性藥物 及/或口服藥物的反應 不佳
身體檢查 (如有)	沒有喘鳴或胸悶	使用支氣管擴張劑，仍有 輕微喘鳴或胸悶	有喘鳴或胸悶，無法 通過使用支氣管擴張 劑緩解
肺功能測試 - FEV1* 或 PEF* - 預期值百分比 (如有)	FEV1 $\geq$ 80%預期值 FEV1 / FVC 正常	FEV1 > 60%預期值但<80% 預期值 FEV1 / FVC 下降5%	FEV1 $\leq$ 60%預期值 FEV1 / FVC 下降超過 5%
年長人士	於適量活動下沒有過 分的呼吸困難 (能夠上落樓梯)	只在做某些活動時受限制 ，但仍能上落樓梯	在正常活動時有顯著 限制

* 備註：FEV1 - 用力吐氣第一秒鐘的吐氣量
PEF - 最大吐氣峰值

核保要求

- 如屬輕度/中度症狀，請提供詳細病況（例如：治療，兩年內的徵狀，無法工作/上學/進行日常活動的天數，住院詳細及住院時間）
- 如情況嚴重，可能須索取主診醫生報告

備註：

「呼吸系統疾病問卷」已內置於iPOS.

核保指引- 僅適合成人使用

		人壽		危疾/ 早期危疾		AIA 唯一摯保 (AOACS)	
		非吸煙人士	吸煙人士	非吸煙人士	吸煙人士	非吸煙人士	吸煙人士
過去 2 年內沒有症狀和治療		標準					
處於發病期或 2 年內出現症狀	輕度	標準	+50% 起*	標準	+50% 起*	標準	人壽保障:+50% 起* 原位癌及癌症保障: 標準
	中度	+50% 起*	+100% 起*	標準	+50%起*	人壽保障:+50% 起* 原位癌及癌症保障: 標準	人壽保障:+100%起* 原位癌及癌症保障: 標準
	嚴重	+100%起*	+150%起*	危疾: +75% 起* 早期危疾: 不保慢性肺病	危疾: +125%起* 早期危疾: 不保慢性肺病	人壽保障:+100%起* 原位癌及癌症保障: 標準	拒絕受保

備註：

* 最後決定視乎客戶目前的健康狀況及/或日常吸煙數量而定

•以下客戶將會個別處理：

a) 重症監護治療 (最近 5 年)

b) 並存慢性阻塞性肺病 (COPD)

核保指引 - 僅適合成人使用

		住院		癌症全方位	
		非吸煙人士	吸煙人士	非吸煙人士	吸煙人士
過去 2 年內沒有症狀和治療		標準			
處於發病期或 2 年內出現症狀	輕度 (沒有慢性阻塞性肺病)	標準	+25% thumbs up 或不保哮喘	標準	
	中度 (沒有慢性阻塞性肺病)	+75% thumbs up 或不保哮喘	+100% thumbs up 或不保哮喘		
	嚴重	拒絕受保	拒絕受保		

備註: thumbs up 靈活核保決定

孤獨性障礙

簡介：患有孤獨症的兒童和成人通常會在言語和非言語交流、社交互動、休閒活動或遊戲中感到困難

徵狀：社交技能障礙

治療

- 行為管理
- 言語治療或職業治療
- 藥物
- 社區支持

風險分類

高功能孤獨症	• 智商(IQ)在70以上 • 感覺運動功能僅受到極小損傷 • 良好的語言技能 • 能夠獨立生活
輕度或中度	• 智商 (IQ) 為35至70 • 有一定溝通能力 • 能夠生活自理 • 學習技能限於較低的學業水平
重度	• 智商(IQ)低於35 • 運動發育不良 • 無法獨立生活

孤獨性障礙



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告
- 學校成績報告和評估報告 (兒童使用)

核保指引

僅適合成人使用:

		人壽	危疾 / 早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	癌症全方位	住院
高功能孤獨症 (未伴有其他神經行為或精神健康症狀或癲癇)		標準	標準	標準	標準	個別考慮
輕度或中度	未伴有其他神經行為或精神健康症狀或癲癇	+50%起*	標準	人壽保障:+50%起* 原位癌及癌症保障: 標準	標準	
	伴有並存的神經行為或精神健康症狀或癲癇	個別考慮				
重度		拒絕受保				

備註: * 核保結果將會根據調查報告而作評估

孤獨性障礙



核保指引

僅適合兒童使用:

		人壽	危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	癌症全方位	早期危疾	住院
2歲或以下:		擱置受保					個別考慮
2歲或以上:						個別考慮，至少不保自閉症及嚴重精神病	
高功能孤獨症 (未伴有其他神經行為或精神健康症狀或癲癇)		標準	標準	標準	標準		
輕度或中度	未伴有其他神經行為或精神健康症狀或癲癇	+50%起*	標準	人壽保障:+50%起* 原位癌及癌症保障: 標準	標準		
	伴有並存的神經行為或精神健康症狀或癲癇	個別考慮					
重度		拒絕受保					

備註：* 核保結果將會根據調查報告而作評估

良性前列腺增生症

簡介：良性前列腺肥大

徵狀：排尿困難; 膀胱不能完全排空

良性前列腺增生症



成因

- 無成因，常見於老年男性

治療

- 口服藥物
- 手術

良性前列腺增生症



核保要求

- 顯微鏡尿液分析 (MU)
- 驗血 (類別Y) – 前列腺特異抗原PSA
- 前列腺超聲波報告(如有)
- 需索取主診醫生報告
- 遞交所有檢查報告 (包括病理報告) – 如有做過手術

核保指引

	人壽	危疾 / 早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
沒有進行手術，前列腺光滑，沒有結節及腎功能沒有受損 (前列腺特異抗原PSA及顯微鏡尿液分析(MU)正常)	標準	標準	+25%或不保前列腺 	標準	標準
前列腺特異性抗原異常	核保指引參照： 前列腺特異性抗原異常				
否則	個別處理*				

備註：

* 核保結果將會根據主診醫生報告和病理報告而作評估



靈活核保決定

乳房疾病

纖維腺瘤 / 乳房纖維囊腫 / 乳房囊腫

簡介：細胞異常生長但不被視為癌變

徵狀：乳房疼痛；乳房腫塊；乳頭分泌物；皮膚小凹陷

乳房疾病



成因

- 乳房細胞異常生長

治療

- 手術切除
- 醫學觀察

乳房疾病



核保要求

- 最近六個月內之乳房超聲波報告
- 病理報告 (如已做切除手術)

核保指引

		人壽	危疾	早期危疾
現有乳房疾病	診斷未確定， 惡性未排除	擱置受保至全面檢測		
	實質腫塊 (包含囊腫 / 任何腫瘤)，惡性排除	標準	根據影像報告 個別考量	根據影像報告個別考量
	乳腺纖維腺病/ 纖維囊性病 • 醫生建議只需要定期觀察 • 沒有接受或被建議活體組織檢查 • 沒有存在或曾經有腫塊病史 • 沒有乳癌家族病史	標準	標準	標準
如做了手術切除 / 抽取 及病理報告確定為良性	單純性乳房囊腫*	標準	標準	標準
	單純性纖維腺瘤 已排除惡性腫瘤並確認無非典型性質	標準	不保 乳房癌#	不保 乳房原位癌#
	纖維囊性病	標準	根據病理報告 個別考量	根據病理報告個別考量

備註: * 除單純性乳房囊腫外，非單純性乳房囊腫及多囊性乳房囊腫須進行評核

如做了手術切除及病理報告確認無非典型性質，目前超聲波報告正常，沒有乳癌或卵巢癌家族病史，可考慮標準受保

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

乳房疾病



核保指引

		AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院
現有乳房疾病	診斷未確定， 惡性未排除	擱置受保至全面檢測	
	實質腫塊 (包含囊腫 / 任何腫瘤)，惡性排除	根據影像報告個別考量	
	乳腺纖維腺病/ 纖維囊性病 •醫生建議只需要定期觀察 •沒有接受或被建議活體組織檢查 •沒有存在或曾經有腫塊病史 •沒有乳癌家族病史	標準	##留置權： 不保 <u>受影響乳房</u> ，賠償比率如下： 等候期 賠償比率 第一至五年: 0% 第六年及以後: 100%
如做了手術切除 / 抽取 及病理報告確定為良性	單純性乳房囊腫*	標準	標準
	單純性纖維腺瘤 已排除惡性腫瘤並確認無非典型性質	人壽保障:標準 原位癌及癌症保障: 不保乳房癌及乳房原位癌 #	若手術於兩年內進行，不保受影響的乳房；其後如果沒有復發， 標準
	纖維囊性病	根據病理報告個別考量	不保受影響的乳房

備註:

- 除單純性乳房囊腫外，非單純性乳房囊腫及多囊性乳房囊腫須進行評核
- # 如做了手術切除及病理報告確認無非典型性質，目前超聲波報告正常，沒有乳癌或卵巢癌家族病史，可考慮標準受保
- ##留置權法不適用於自願醫保產品



靈活核保決定

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

乳房疾病



核保要求

- 最近六個月內之乳房超聲波報告
- 病理報告 (如已做切除手術)

核保指引

		癌症全方位
現有乳房疾病	診斷未確定 惡性未排除	擱置受保至完全檢查
	實質腫塊 (包含囊腫 / 任何腫瘤) 發現 < 6個月, 並符合以下任何一個: a) 受保人年齡 ≥ 40歲, b) 乳癌家族史	擱置受保六個月
	實質腫塊 (包含囊腫 / 任何腫瘤) 發現 < 6個月, 並符合全部以下: a) 受保人年齡 < 40歲, 及 b) 無乳癌家族史	不保 乳房癌 及乳房切除術治療之乳房原位癌 及乳房原位癌
	實質腫塊 發現 > 6個月, 兩次乳房超聲波間隔六個月以上顯示大小穩定	不保 乳房癌 及乳房切除術治療之乳房原位癌 及乳房原位癌
如做了手術切除 / 抽取 及 病理報告確定為良性	單純性乳房囊腫*	標準
	單純性纖維腺瘤#	標準
	乳腺纖維腺病/纖維囊性病#	標準

備註:

* 除單純性乳房囊腫外, 非單純性乳房囊腫及多囊性乳房囊腫須進行評核

決定於病理報告

「多重智倍保」良性病變賠償

核保要求

- 過往的造影檢查報告及病理報告
- 於六個月內在#首選的化驗所進行的乳房超聲波報告及符合所需內容*
- 須遞交「腫瘤 / 囊腫問卷」
- 主診醫生報告(APS) (如需要)

* 乳房超聲波報告內容應包括:

- 超聲波對雙側乳房進行檢查;
- 指出發現病變所在的乳房及相關所見（左側或右側乳房病變）;
- 須結合時鐘法或象限法定位乳房內病變的徑向位置;
- 病變的大小及程度（包括最大直徑及/或腫瘤的體積）;
- 內部迴聲（低迴聲/等迴聲/高迴聲或實性/囊性）;
- 皮膚/乳頭的描述；是否有鈣化及相關的描述;
- 是否有腋窩淋巴結及相關的描述;
- BIRADS的分級;
- 做出診斷；可能的鑑別診斷；提供建議是否需進一步影像檢查及/或其他檢查來確定病變性質。

有關首選的化驗所的詳情，請參閱附錄甲

「多重智倍保」良性病變賠償

		良性病變賠償
現有乳房疾病	- 年齡為65歲以下之女性 - 沒有直系親屬在50歲之前患有乳癌及/或卵巢癌的家族史 - 乳房X光檢查診斷：BIRADS第1、2或3階段 - 依照超聲波診斷**並根據AIA目前的核保指引，該申請被評為標準保費級別及不保事項為乳癌及乳房原位癌。另外，沒有其他不明確的健康狀況導致額外保費、不保事項、拒絕受保擱置或延期的決定 - 過往沒有進行過活體組織檢查或外科手術，否則該申請將根據病理報告進行個別評估	為乳房原位癌及乳癌提供相等於20%原有保額的良性疾病保障 核保決定視乎最近期乳房超聲波檢查的結果
如做了手術切除 / 抽取及病理報告確定為良性	單純性乳房囊腫*	標準
	單純性纖維腺瘤#	標準
	乳腺纖維腺病/纖維囊性病#	標準

備註:

* 除單純性乳房囊腫外，非單純性乳房囊腫及多囊性乳房囊腫須進行評核

決定於病理報告

** 診斷: 纖維腺瘤、囊腫（多發性囊腫）、積乳囊腫、假血管瘤基質增生、硬化性腺病、放射狀瘢痕、複合硬化性病變、乳腺鈣化、上皮增生（無活組織檢查）、血腫、血管瘤、脂肪瘤及基質腫瘤

支氣管炎

簡介：氣管炎是一種急性發作的支氣管（氣道）炎症

徵狀：咳嗽;生產粘液;呼吸急促;輕微發燒和發冷;胸口痛

支氣管炎



成因

- 病毒或細菌感染

治療

- 根據嚴重程度服用口服藥物

核保要求

- 體檢 (如有需要)
- 主診醫生報告 (如有需要)

備註:

「呼吸系統疾病問卷」已內置於iPOS.

支氣管炎



核保指引 僅適合成人使用:

	人壽	危疾/ 早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
單次發病，現在不用治療	標準				
否則	個別考慮*				

備註：* 最後決定視乎客戶目前的健康狀況及/或日常吸煙數量而定

-以下客戶將會個別處理：

- i) 口服或靜脈注射皮質類固醇治療
- ii) 心臟衰竭, 肺性心臟病或肺容量手術
- iii) 支氣管擴張

支氣管炎



核保指引 僅適合兒童使用:

	人壽	危疾/ 早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摺保 (AOACS)
1歲或1歲以下	擱置受保				
1歲以上，病發1-2次，已痊愈和沒有後遺症	標準	標準	個別考慮*	標準	標準

備註：* 最後決定視乎客戶目前的健康狀況而定

以下客戶將會個別處理：

- i) 口服或靜脈注射皮質類固醇治療
- ii) 心臟衰竭, 肺性心臟病或肺容量手術
- iii) 支氣管擴張

癌症

簡介： 由不正常組織發展成的癌症

徵狀： 腫塊；囊腫；結節

成因

- 周圍細胞的分裂趨於旺盛，細胞因缺陷或突变，因而誘發癌症

治療

- 手術
- 放射治療 / 化學治療

常見癌症

- 乳癌
- 甲狀腺癌
- 肺癌
- 結腸直腸癌
- 前列腺癌

核保要求

- 乳癌
 - 主診醫生報告
 - 遞交所有檢查報告 (包括病理報告)
- 甲狀腺癌
 - 驗血 (類別O)
 - 主診醫生報告
 - 遞交所有檢查報告 (包括病理報告)
- 肺癌
 - 主診醫生報告
 - 遞交所有檢查報告 (包括病理報告)
- 結腸直腸癌
 - 主診醫生報告
 - 遞交所有檢查報告 (包括病理報告)
- 前列腺癌
 - 顯微鏡尿液分析 (MU)
 - 驗血 (類別Y) - PSA
 - 主診醫生報告
 - 遞交所有檢查報告 (包括病理報告)

癌症



核保指引

	人壽	危疾 / 早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
所有情況	個別考慮*				

備註：*核保結果將會根據主診醫生報告和病理報告的結果包括腫瘤分期，腫瘤大小，受累淋巴結的數量和程度，有否轉移，治療的方法，完成治療距今的年數和現時狀況而作評估。

腦血管疾病

中風

簡介：任何影響大腦供血的疾病, 導致突發性神經系統及 / 或
視覺受損超過二十四小時

徵狀：突發性癱瘓；突然喪失一邊或甚至兩邊視力；復視；發音
困難；運動失調；眩暈；失語；嚴重頭痛；抽搐及突然喪
失知覺

位置：血管

腦血管疾病

短暫性腦缺血發作 (TIA)

簡介：任何影響大腦供血的疾病，導致突發性神經系統及 / 或視覺受損少於二十四小時

徵狀：短暫的神經症狀

位置：血管

中風 / 短暫性腦缺血發作 (TIA)



成因

- 高血壓；冠狀動脈性心臟病；心房顫動；糖尿病；高膽固醇血症；吸煙；腦腫瘤

治療

- 藥物控制高血壓、糖尿病和高脂血症；停止吸煙；康復期內結紮動脈瘤

中風 / 短暫性腦缺血發作 (TIA)



風險分類

TIA	輕度中風	中度中風	重度中風
- 症狀持續不超過24小時 (例如言語困難、視力喪失 / 一過性黑朦、感覺喪失等) - 可完全恢復，無後遺症狀	- 症狀（言語缺陷，視覺障礙，感覺喪失等）持續超過24小時，但是可完全恢復或僅遺留輕微症狀 - 可以繼續從事日常工作且無任何限制 - 長期性可逆性缺血性神經功能障礙 (PRIND)	- 慢性後遺症狀但無需他人扶助，可獨立行走 - 有些日常工作受限 - 需要一些少量的幫助在於日常活動	- 影響日常生活 - 認知障礙，由於日常生活活動能力或實用日常生活活動能力嚴重受損，需要輪椅或不能自理，日常生活需要幫助

中風 / 短暫性腦缺血發作 (TIA)



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告
- 遞交所有檢查報告 (包括磁力共振、電腦掃描等)

核保指引

	人壽	AIA 唯一摯保 (AOACS)	癌症全方位	危疾 / 早期危疾 / 住院
最後一次病發六個月內	擱置受保		標準	拒絕受保
最後一次病發六個月後	會有較高保費評級或拒絕受保， 視乎中風類型，病發嚴重程度，發作次數， 病情控制、有否按時覆診治療、 併發症嚴重程度或其他心血管 風險因素*		標準	拒絕受保

* 備註: 心血管風險因素: 例如 吸煙習慣, 過重, 高血壓, 糖尿病, 血脂異常等

冠狀動脈性心臟病 (CAD)

- 簡介：冠狀動脈循環未能提供足夠的血流量運送氧氣及營養到心臟
- 徵狀：非典型胸痛；心絞痛；疲勞；呼吸困難；暈厥；心律失常；
心肌梗塞；急性充血性心臟衰竭；心臟性猝死
- 位置：心臟

冠狀動脈性心臟病 (CAD)



成因

- 冠狀動脈粥樣硬化致血管逐漸狹窄；繼發性的動脈粥樣硬化斑塊破裂令血栓突然形成；血管痙攣

治療

- 冠狀動脈搭橋術，經皮穿腔冠狀動脈血管置入支架成形術 (通波仔 PTCA)；控制其他心血管風險因素，如高脂血症、高血壓、糖尿病、吸煙、體重等

冠狀動脈性心臟病 (CAD)



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告
- 遞交所有有關檢查報告 (包括冠狀動脈造影報告等)
- 靜態心電圖 (ECG) (如有須要)

冠狀動脈性心臟病 (CAD)



核保指引

以下僅供參考，最終評級取決於受控制的程度，治療的依從性，併發症的嚴重程度

人壽	危疾 / 早期危疾	住院	癌症全方位
擱置受保，如： 1. 於最近一個月內確診或接受手術或 2. 受保人為 40 歲或以下 其他個案則按其嚴重程度，其他心臟問題及其他心血管風險因素*作個別考慮	拒絕受保	通常拒絕受保 其他個案則按其嚴重程度，其他心臟問題及其他心血管風險因素*作個別考慮	擱置受保，如受保人於最近三個月內確診或接受手術 其他個案則按其嚴重程度，其他心臟問題及其他心血管風險因素*作個別考慮

* 備註：心血管風險因素：例如 吸煙習慣，過重，高血壓，糖尿病，血脂異常等

冠狀動脈性心臟病 (CAD)



核保指引

以下僅供參考，最終評級取決於受控制的程度，治療的依從性，併發症的嚴重程度

AIA 唯一摺保 (AOACS)

人壽保障:

擱置受保，如:

1. 於最近一個月內確診或接受手術或
2. 受保人為 40 歲或以下

其他個案則按其嚴重程度, 其他心臟問題及其他心血管風險因素*作個別考慮

原位癌及癌症保障:

如因糖尿病，體格，或家族病史加價 $\geq +25\%$ ：則需要增加糖尿病之附加保費

如目前為吸煙人士：+25%

否則：標準

* 備註：心血管風險因素：例如 吸煙習慣, 過重, 高血壓, 糖尿病, 血脂異常等

2019冠狀病毒病

簡介：2019冠狀病毒病是由新出現的冠狀病毒SARS-CoV-2引發的疾病

徵狀：沒有症狀; 發熱; 乾咳; 呼吸困難等

成因

- 冠狀病毒被認為源於能夠感染人類的動物宿主，然後繼續從一個人傳播到其他人。

治療

- 抗生素
- 補液
- 鎮痛藥

核保要求*

- 詳細病況（例如：症狀(如有)，是否需要治療、入院等詳情，現時狀況及是否有後遺症等）
- 詳細出院記錄 / 醫療報告（如有）
- 主診醫生報告(APS)（如曾經住院，可能需要）
- 體檢(可能需要)

*由於新型冠狀病毒不斷變化，因此核保要求可能會不時更新

2019冠狀病毒病



核保指引

		人壽	危疾 / 早期危疾	住院	AIA 唯一摺保 (AOACS)	癌症全方位
因可能或已知的與2019冠狀病毒病密切接觸或因旅行而需自我隔離/自行監察*，無症狀		擱置受保直至隔離/自行監察*完成及所有必需的測試（例如 PCR, 核酸檢測, 快速抗原測試）均確認為陰性。其後標準				標準
2019冠狀病毒病 相關症狀或抗原 檢測結果陽性	沒有入院治療 或 曾經接受入院治療但住院期間不需要插管/呼吸機以幫助呼吸：					
	自我隔離/自行監察*已完成，PCR/核酸檢測/快速抗原測試結果恢復正常。 已完全康復，沒有任何症狀例如極度疲勞及呼吸急促等，恢復正常的身體功能和活動。	完全康復後，標準				標準
	否則	擱置受保				
	曾經接受入院治療並且住院期間曾經需要插管/呼吸機以幫助呼吸：					
	已完全康復，沒有任何症狀例如極度疲勞及呼吸急促等，恢復正常的身體功能和活動。 完全康復超過12個月。	完全康復超過12個月後，標準				標準
	否則	擱置受保				

*包括根據政府不時更新的檢疫/自我隔離/醫學監測/自行監察和測試要求。

註：- 由於2019冠狀病毒病不斷變化，因此核保指引可能會不時更新。
- 最終核保決定將取決於是否存在併發症 / 後遺症。

糖尿病 (DM)

簡介： 慢性高血糖屬於一種新陳代謝失調疾病，起因是由於身體缺乏胰島素或對胰島素產生抗拒

徵狀： 無症狀；口渴；體重下降

I 型糖尿病 (胰島素依賴型糖尿病 / 幼年糖尿病)

II 型糖尿病 (非胰島素依賴型糖尿病 / 成年糖尿病)

成因

- 胰臟減少分泌胰島素或身體各組織對胰島素反應不佳

併發症

- 大血管疾病 例如：中風、短暫性腦缺血發作 (TIA)、心肌缺血或梗塞
- 微血管病變 例如：失明、腎病
- 糖尿引致腎臟病變 例如：蛋白尿、腎功能不全
- 糖尿引致視網膜病變 例如：失明、白內障
- 糖尿引致神經病變 例如：四肢感覺不良、足部潰瘍及壞疽
- 感染：常見於糖尿病控制不佳的病人

治療

- 口服藥物；注射藥物；飲食控制；運動；胰島素噴鼻劑；幹細胞移植等

診斷標準

- 空腹血糖 (FBS) ≥ 7.0 mmol/l
或
- 葡萄糖耐量兩小時測試 ≥ 11.1 mmol/l
或
- 糖化血紅蛋白 (HbA1c) $\geq 6.5\%$

核保要求

- 體檢
- 驗血 (類別N) 及 驗血 (類別M) - 空腹 最少6 小時
- 顯微鏡尿液分析 (MU) - 空腹最少6 小時
- 靜態心電圖 (ECG) (如購買住院產品則須要)
- 驗血 (類別B) (如購買住院產品則須要)
- 主診醫生報告 (如購買住院產品則須要, 其他產品則視乎客人的情況而定)

核保指引

人壽	危疾 / 早期危疾	住院	AIAIA 唯一摯保 (AOACS)
非標準，保費級別根據年齡，控制程度，有否按時覆診治療，併發症嚴重程度，患糖尿病年期及心血管風險因素**而作評估			

** 備註：心血管風險因素：例如 吸煙習慣，過重, 高血壓，糖尿病，血脂異常等

濕疹/ 皮炎

簡介：急性/慢性皮膚的表層炎症

徵狀：皮膚敏感; 瘙癢; 紅腫;

成因

- 遺傳；免疫系統功能失調；環境

風險分類

- 異位性皮炎/濕疹
- 剝落性皮炎/濕疹

治療

- 外用乳霜
- 口服藥物
- 光照治療

核保要求

- 體檢 (如有需要)
- 主診醫生報告 (如有需要)

核保指引

	人壽	危疾 / 早期危疾	癌症全方位	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
異位性皮炎/濕疹	標準				
剝落性皮炎/濕疹	擱置受保				

眼疾

白內障

簡介：眼球中的晶體混濁或不透光，受影響的眼睛會慢慢惡化

徵狀：視力下降；看燈光時周圍有光暈及感到刺眼

成因

- 遺傳；吸煙；暴露在輻射中及過度暴露在紫外線下；長期使用皮質類固醇、各種炎症及代謝異常

治療

- 晶體摘除手術

風險分類

未成熟	晶體仍有部份清澈
成熟	晶體完全不透光
過度成熟	會有一個液化的表面通過包膜洩漏或導致發炎

眼疾

視網膜脫落

簡介：當視網膜內層與上皮之間形成缺口會導致部分或全部視網膜脫落

徵狀：無症狀；視力模糊；頭痛；眼痛；無痛性喪失視力

成因

- 原發性；腫瘤；外傷；完成白內障手術後；糖尿病引起的視網膜病變

治療

- 手術治療或激光凝固

視網膜脫落 / 白內障



核保要求

- 需要詳述病發日期，眼疾的種類和治療
- 目前的視力狀況

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
白內障	標準	如手術後視力正常 標準 否則不保失明	如手術後視力正常 標準 否則不保單眼失明 及失明	年齡 > 16， 不保白內障 年齡 < 16， 個別考量	標準	標準
視網膜脫落	標準	不保失明	不保單眼失明及失明	不保受該影響 的眼睛	標準	標準

眼疾

青光眼

簡介: 眼球內壓力過高,導致視覺神經萎縮, 損傷以致永久性的失明

徵狀: 無徵狀 ; 逐漸喪失視力 ; 頭痛 ; 眼痛面痛 ; 無痛性喪失視力

青光眼



成因

- 創傷; 長期使用皮質類固醇; 各種炎症及代謝異常

治療

- 口服藥物
- 手術治療

核保要求

- 需要詳述病發日期，眼疾的種類和治療，及目前的視力狀況
- 體檢，以確定當前的視力
- 如情況嚴重，須索取主診醫生報告

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
青光眼	標準	標準如手術後視力 20/40(或 6/12)或更好 及無併發症 否則不保失明	標準如手術後視力 20/40(或 6/12)或更好 及無併發症 否則不保單眼失明及 失明	不保受該影響 的眼睛	標準	標準

結腸直腸癌 / 乳癌 / 其它癌症之家族病史

簡介：直系親屬被診斷患有癌症

徵狀：無症狀

結腸直腸癌 / 乳癌之家族病史



成因

- 屬遺傳性疾病

治療

- 預防藥物
- 定期身體檢查

乳癌之家族病史



核保要求

- 詳述該直系親屬關係、癌症種類及發病年齡
- 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

核保指引

		人壽	危疾	早期危疾	住院
一名家族成員	於 40 歲前確診	標準	+50% 或 不保乳房癌及卵 巢癌	不保乳房原位癌 及女性原位癌 (卵巢)	+50% 或不保雙 乳房
	於 40 歲或之後 確診		標準	標準	標準
兩名或以上的家族成員於 40 歲 前被診斷患乳癌		+50%	不保乳房癌及卵 巢癌	不保乳房原位癌 及女性原位癌 (卵巢)	不保雙乳房

備註: 以上僅適用於女性受保人
如受保人曾接受基因測試，核保結果將會根據測試結果而受影響

乳癌之家族病史



核保指引

		AIA 唯一摯保 (AOACS)
一名家族成員	於 40 歲前確診	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 不保乳房癌及卵巢癌, 乳房原位癌及女性原位癌 (卵巢) 或 +50%及不保乳房原位癌及女性原位癌 (卵巢)
	於 40 歲或之後確診	標準
兩名或以上的家族成員於 40 歲前被診斷患乳癌		人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: 不保乳房癌及卵巢癌, 乳房原位癌及女性原位癌 (卵巢)

備註: 以上僅適用於女性受保人
如受保人曾接受基因測試, 核保結果將會根據測試結果而受影響

核保指引

	癌症全方位
一名家族成員於60歲前確診乳癌	+50% 或 不保乳房癌及乳房原位癌
兩名或以上家族成員於60歲前確診乳癌	不保 乳房癌； 卵巢癌； 乳房原位癌 及女性原位癌 (卵巢)
一名家族成員於60歲前確診乳癌 及 一名家族成員於60歲前確診卵巢癌	不保 乳房癌；卵巢癌； 乳房原位癌 及 女性原位癌 (卵巢)

備註: 以上僅適用於女性受保人
如受保人曾接受基因測試，核保結果將會根據測試結果而受影響

大腸癌之家族病史



核保要求

- 詳述該直系親屬關係、癌症種類及發病年齡
- 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

核保指引

	人壽	危疾 / 早期危疾	住院
一名家族成員患病	標準	標準	受保人年齡 < 50 : (i) 家族成員於 60 歲或之前確診 : 不保結腸和直腸 (ii) 家族成員於 60 歲之後確診 : 標準
			受保人年齡 ≥ 50 歲 : 標準
兩名家族成員或以上患病	受保人年齡 < 50 : +25%	受保人年齡 < 50 : +50%或不保大腸癌 及結腸原位癌，直腸 原位癌	不保結腸和直腸
	受保人年齡 ≥ 50 : 標準	受保人年齡 ≥ 50 : 標準	

備註: 以上只適用於非家族性腺瘤性息肉病
如受保人曾接受基因測試，核保結果將會根據測試結果而受影響

大腸癌之家族病史



核保指引

		AIA 唯一摯保 (AOACS)
一名家族成員患病		標準
兩名家族成員或以上患病	受保人年齡 < 50	人壽保障: +25% 原位癌及癌症保障: +50%或不保大腸癌及結腸原位癌，直腸原位癌
	受保人年齡 ≥ 50	標準

備註: 以上只適用於非家族性腺瘤性息肉病
如受保人曾接受基因測試，核保結果將會根據測試結果而受影響

大腸癌之家族病史



核保指引

	癌症全方位
一名家族成員於 60 歲之前確診	標準 (如受保人於過去三年內有進行大腸鏡檢查及結果正常)
	否則 不保結腸原位癌，直腸原位癌，大腸癌
兩名家族成員於 60 歲之前確診	不保結腸原位癌，直腸原位癌，大腸癌
多於兩名家族成員患結腸直腸癌	個別考慮
一名家族成員於 60 歲後確診，受保人並無進行大腸鏡檢查	標準

備註: 以上只適用於非家族性腺瘤性息肉病
如受保人曾接受基因測試，核保結果將會根據測試結果而受影響

其它癌症之家族病史



核保指引

	人壽 / 危疾 / 早期危疾 / 住院/AIA 唯一摯保 (AOACS)	癌症全方位
一名家族成員於 60 歲前 被診斷患癌	標準	個別考慮
兩名或以上家族成員於 60 歲前診斷患癌	個別考慮	

以上不適用於家族性腺瘤性息肉、大腸癌、乳腺癌、卵巢癌

糖尿病之家族病史

簡介
徵狀

:直系親屬被診斷患有糖尿病
:無症狀

成因

- 1 型和 2 型糖尿病都屬於多因素疾病，而家族史在其中起到了重要作用。

治療

- 定期身體檢查

糖尿病之家族病史



核保要求

- 詳述該直系親屬關係、糖尿病種類及發病年齡
- 直系親屬包括父母及兄弟姐妹

核保指引

僅適合成人使用:

1型糖尿病	人壽	危疾	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院	癌症全方位
一名家族成員確診糖尿病:	標準					
兩名或以上家族成員 確診糖尿病:	一名家族成員於60歲前確診					
	申請時的年齡:					
	少於或等於55	標準			+25%	標準
	大於55及少於65				+25%	
	大於或等於65				標準	
	兩名或以上家族成員於60歲前確診					
	申請時的年齡:					
	少於或等於55	標準			+50%	標準
	大於55及少於65				+25%	
	大於或等於65				標準	

糖尿病之家族病史



核保指引 僅適合成人使用:

2型糖尿病		人壽	危疾	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院	癌症全方位
一名家族成員確診糖尿病：		標準					
兩名或以上家族成員 確診糖尿病：	一名家族成員於60歲前確診						
	申請時的年齡：						
	少於或等於55	視乎於心血管疾病風險因素， 可能非標準保費				+25%	標準
	大於55及少於65					+25%	
	大於或等於65					標準	
	兩名或以上家族成員於60歲前確診						
	申請時的年齡：						
	少於或等於55	視乎於心血管疾病風險因素， 可能非標準保費				+50%	標準
	大於55及少於65					+25%	
	大於或等於65					標準	

柏金遜症之家族病史

簡介：直系親屬被診斷患有柏金遜症
徵狀：無症狀

帕金森症之家族病史



成因

- 呈家族式發病，並已明確其常染色體顯性和隱性基因突變。帕金森氏病的家族史使罹患該疾病的風險增加 3 至 6 倍。

治療

- 定期身體檢查

柏金遜症之家族病史



核保要求

- 詳述該直系親屬關係、柏金遜症發病年齡
- 直系親屬包括父母及兄弟姊妹

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
受保人年齡 > 65, 無神經系統症狀的現症或病史:	標準	標準	標準	標準	標準	標準
受保人年齡 ≤ 65						
一名家族成員於 50 歲或之前確診柏金遜症:	標準	不保 柏金遜症	不保 次級嚴重帕金森病	不保 柏金遜症	標準	標準
一名家族成員於 50 歲之後確診柏金遜症:	標準	標準	標準		標準	標準
多於或兩名親屬確診柏金遜症:	標準	不保 柏金遜症	不保 次級嚴重帕金森病		標準	標準

脂肪肝

簡介：脂肪於肝臟實質組織內沉積

徵狀：一般無症狀；輕微肝功能異常

成因

- 肥胖；感染及肝臟纖維化改變；非酒精性脂肪肝病(NAFLD)；乙型或丙型肝炎；酗酒；藥物副作用

治療

- 改變生活方式以減輕體重；透過治療糖尿病、高血壓及高膽固醇等相關疾病來控制脂肪肝

脂肪肝



核保要求

- 驗血 (類別I) (空腹6小時)
- 驗血(類別J)

核保指引

如血液測試結果正常:

人壽	標準
危疾 / 早期危疾 / 癌症全方位	標準
住院	標準
AIA 唯一摯保 (AOACS)	標準

女性生殖器官疾病

子宮頸上皮細胞瘤樣增生 (CIN)

- 簡介：子宮頸細胞異常增生，不正常細胞開始出現於子宮頸
- 徵狀：異常出血；陰道產生異常分泌物
- 位置：子宮頸

子宮頸上皮細胞瘤樣增生 (CIN)



成因

- 較早開始性生活；濫交及性器官疱疹；感染人類乳頭瘤狀病毒 (HPV)

治療

- 手術－錐形活組織檢查；子宮切除術；電環切除術 (LEEP)

子宮頸上皮細胞瘤樣增生 (CIN)



風險分類

FIGO* 及 WHO*	Bethesda 系統	細胞變化說明
CIN I	LSIL (低分級鱗狀上皮內病變)	輕度不典型增生
CIN II	HSIL (高分級上皮內病變)	中度不典型增生
CIN III	原位癌	重度不典型增生或原位癌

* 備註：FIGO – 國際婦產科聯盟
WHO – 世界衛生組織

子宮頸上皮細胞瘤樣增生 (CIN)

核保要求

- 病理報告
- 手術後跟進之子宮頸塗片檢查報告
- 主診醫生報告，(如需復診或CIN II及以上)

核保指引

病症		人壽	危疾	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)
CIN I	HPV 陰性	標準			
CIN II	HPV 陰性	標準	標準	不保子宮頸原位癌	人壽保障:標準 原位癌及癌症保障: 不保子宮頸原位癌
CIN III	切除後至少6個月的子宮頸塗片檢查報告為正常	標準	標準	不保子宮頸原位癌	
其他個案		個別考慮			

子宮頸上皮細胞瘤樣增生 (CIN)

核保指引

診斷後跟進之子宮頸塗片檢查報告 正常以及HPV陰性	住院
CIN I	兩年內宮頸塗片檢查報告正常以及HPV陰性，不保子宮頸之後標準
CIN II CIN III	完全切除，確證無入侵性細胞 切除後至少一年，宮頸塗片檢查報告正常以及HPV陰性，不保子宮頸
其他個案	擱置受保

診斷後跟進之子宮頸塗片檢查報告 正常以及HPV陰性	癌症全方位
CIN I	標準
CIN II	三年內宮頸塗片檢查報告正常以及HPV陰性，不保子宮頸原位癌及 / 或陰道原位癌及 / 或外陰原位癌，之後標準
CIN III	五年內宮頸塗片檢查報告正常以及HPV陰性，不保子宮頸原位癌及陰道原位癌及 / 或外陰原位癌，子宮頸癌及陰道癌及 / 或陰癌之後標準
其他個案	擱置受保

女性生殖器官疾病

卵巢囊腫

簡介：液體或半固體囊腫於卵巢表面或內部形成

徵狀：盆腔疼痛；月經異常；不孕；無症狀

女性生殖器官疾病

子宮纖維瘤

簡介：子宮良性平滑肌瘤

徵狀：無症狀；月經過多；痛經；尿頻；尿瀦留及腹部不適

卵巢囊腫 / 子宮纖維瘤



成因

- **卵巢囊腫**：在排卵時，卵泡未能破裂並釋放卵子。因卵泡不被吸收；液體存在於卵泡內並形成囊腫。囊腫形成可能與卵巢惡性腫瘤有關。
- **子宮纖維瘤**：不明

治療

- 手術切除；口服避孕藥

卵巢囊腫 / 子宮纖維瘤



核保要求

- 最近半年內之盤腔超聲波報告
- 病理報告 (如已做切除手術)

核保指引

	人壽	癌症全方位	危疾	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院
單純性卵巢囊腫	標準	標準	標準	標準	標準	不保卵巢
子宮纖維瘤，無任何現有症狀 (例如: 經血過量，貧血，背痛)	標準	標準*	標準*	標準*	標準*	不保子宮^
如做了手術切除及病理報告確定為良性	標準	標準	標準	標準	標準	標準

備註：

- 最後決定取決於腫瘤大小
- ^ 如纖維瘤穩已存在超過一年並狀況穩定，可考慮不保“子宮纖維瘤”。這將取決於腫瘤的數量和大小。需要提供相關的超聲報告或主診醫生報告 (APS) 進行審核。

「多重智倍保」良性病變賠償

核保要求

- 過往的盤腔超聲波報告(如有)
- 於六個月內在首選的化驗所#進行的盤腔超聲波報告及符合所需內容*
- 須遞交「腫瘤 / 囊腫問卷」
- 主診醫生報告(APS) (如需要)

* 盤腔超聲波報告內容應包括:

- 盆腔的超聲波報告的詳述包括子宮肌瘤的大小、數量和位置;
- 子宮內膜的情況;
- 附件腫塊;
- Douglas腔積液情況;
- 卵巢的情況

有關首選的化驗所的詳情，請參閱附錄乙

子宮纖維瘤



「多重智倍保」良性病變賠償 核保指引

	良性病變賠償
良性子宮肌瘤及出現相關症狀（重度月經出血，子宮肌瘤引起的腹痛，子宮肌瘤增多或增大）	擱置受保
- 於盆腔超聲波報告確診子宮肌瘤； - 年齡為50歲或以下之女性； - 沒有直系親屬在50歲之前患有子宮癌的家族史	為子宮原位癌及子宮癌提供相等於20%原有保額的良性疾病保障
沒有進行過活體組織檢查或外科手術，否則病例將根據病理報告進行個別評估	

多囊性卵巢症

簡介: 一組複雜的症候群，包括經期不正常、不孕、多毛症、肥胖、過剩的男性賀爾蒙及胰島素耐受(拮抗), 通常具有多囊性卵巢

徵狀: 月經不規則; 肥胖; 不孕

多囊性卵巢症



成因

- 基因遺傳; 胰島素拮抗

治療

- 體重控制
- 藥物治療（口服避孕藥，荷爾蒙治療等）
- 手術治療

核保要求

- 體檢
- 驗血(類別N) - 空腹最少6小時
- 驗血(類別M) - 空腹最少6小時
- 顯微鏡尿液分析(MU) [月經期一星期後]
- 主診醫生報告(如需要)
- 遞交所有檢查報告（例如：最近六個月內之盤腔超聲波報告）

多囊性卵巢症



核保指引 僅適合成人使用:

風險分類		人壽	危疾/早期 危疾	AIA 唯一摺保 (AOACS)	住院	癌症全方位
有完整檢 查記錄	沒有心血 管疾病風 險	標準	標準	標準	不保雙卵巢	如若無月經 相關的病症 則標準
	存在心血 管疾病風 險*	個別考慮	個別考慮	個別考慮	不保雙卵巢 及加上所有 心血管疾病 風險額外保 費之總和	個別考慮
沒有完整檢查記錄		+50% 起	+50% 起	+50% 起		個別考慮

備註:

* 心血管疾病風險包括: 肥胖, 高血壓, 高血脂症或 糖尿病等

膽囊疾病

膽囊息肉

簡介：膽囊壁上的息肉樣病變

徵狀：無症狀或有時上腹部疼痛

膽囊息肉

成因

- 不詳; 可能與年齡增長和出現膽石有關

治療

- 醫學觀察
- 手術切除如膽囊切除術

膽囊疾病

膽石

簡介：由膽汁形成的結晶分佈在膽囊及膽管

徵狀：上腹疼痛或 無症狀

膽石



成因

- 不詳; 通常在例行體檢中發現

治療

- 醫學觀察
- 手術切除

核保要求

- 需要詳述病發情況如膽石或膽囊息肉尺寸, 併發症, 治療, 出現的次數和頻率及所有檢查結果
- 遞交所有有關檢查報告(包括上腹超聲波, 病理報告等)

膽囊息肉/膽石



核保指引

	治療	人壽	危疾/早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院	癌症全方位
膽囊息肉	- 少於6mm - 息肉大小於2年或以上無明顯變化 - 醫生建議無需治療/進行手術	標準			##留置權: 不保膽囊及膽管系統， 賠償比率如下： 等候期 第一至兩年: 0% 第三年: 50% 第四年及以後: 100% 	標準
	- 無需治療 - 超聲波報告確定息肉少於10mm及六個月內息肉沒有明顯變化	標準			不保膽囊及膽管系統	標準
	息肉等於或大於10mm或息肉增大	擱置受保				
	已做切除手術及病理報告確定為良性	標準			標準	標準
膽石	存在	標準	標準如無症狀（疼痛，嘔吐，作嘔）或意外發現。 否則擱置受保	標準如無症狀（疼痛，嘔吐，作嘔）或意外發現。 否則個別考慮	不保膽囊及膽管系統	標準
	已做膽囊切除術三個月，完全康復	標準			標準	標準



備註: 靈活核保決定

##留置權法不適用於自願醫保產品

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA - INTERNAL]

腸胃道疾病

胃炎 / 消化性潰瘍

簡介：腸胃道疾病是指上消化道潰瘍性疾病。如腸胃道的自然保護不正常運作，胃酸和一些酵素可以破壞腸胃道的壁膜

徵狀：消化不良；胃灼熱；噁心；食慾不振；腹部疼痛並於進食後情況會更甚及胃腸道出血

成因

- 阿士匹靈或消炎藥，如布洛芬；酒精；吸煙；胃部感染幽門螺旋菌；胃壁膜的保護層被侵蝕

治療

- 口服藥物
- 情況嚴重可能需要做手術

胃炎



核保要求

- 如情況嚴重，須要主診醫生報告
- 如曾接受胃鏡檢查及/或活組織檢查，須遞交報告
- 如曾接受手術，須遞交病理報告

核保指引

		人壽	危疾/ 早期危疾	AIA 唯一摺保 (AOACS)	住院	癌症全方位
急性胃炎，已完全康復，無併發症， 無癌症病變，幽門螺旋桿菌測試為陰性		標準	標準	標準	出院後三個月內不保胃炎； 否則標準	標準
慢性胃炎	慢性胃炎，已充分調查胃活檢報告 並無細胞病變/化生/萎縮，幽門螺旋桿菌測試為陰性，沒有持續治療	標準	標準	標準	##留置權： 不保胃炎，賠償比率如下： 等候期 賠償比率 第一至兩年: 0% 第三年: 25% 第四年: 50% 第五年或以後: 100%	標準
	胃炎經常嚴重復發(有出血病史) 及最後病發日期少於一年， 充分調查，無感染幽門螺旋桿菌， 胃活檢報告無異常	+50% 起*	+50% 起*	人壽保障: +50% 起* 原位癌及癌症保障: +50% 起*	+50% 起* 	不保胃癌

備註：*以上核保指引不包括其他胃炎或伴有併發症



靈活核保決定

##留置權法不適用於自願醫保產品

消化性潰瘍



成因

- 幽門螺旋菌殖居在胃竇是一個主要引致慢性炎症的因素
- 兩種常見的消化性潰瘍 - 胃潰瘍和十二指腸潰瘍

治療

- 口服藥物
- 情況嚴重可能需要做手術

核保要求

- 如曾接受胃鏡檢查及/或活組織檢查，須遞交報告
- 如曾接受手術，須遞交病理報告

核保指引

	人壽	危疾 / 早期危疾 / 癌症全方位	住院
口服藥物 無需手術			
對治療有良好反應			如病史在三年之內或經常復發 - 不保消化性潰瘍
最後徵狀出現於兩年之內	+25%	+25% 起	
最後徵狀出現超過兩年	標準	標準	
對治療的反應不好，頻繁復發：			如最後徵狀出現或治療超過三年 - 標準
最後徵狀出現於兩年之內	+50%	+50% 起	
最後徵狀出現超過兩年	標準	標準	
曾接受手術 完全康復 無徵狀			
全胃切除術及胃出口梗阻手術以外的所有手術，無復發	標準	標準	不保消化性潰瘍
因良性潰瘍進行全胃切除術	+50%	+50% 起	不保消化性潰瘍

備註：以上核保指引不包括持續使用非類固醇類消炎藥或皮質類固醇的情況，傾食症候群，卓-艾二氏綜合徵及酒精引起的消化性潰瘍

消化性潰瘍



核保指引

AIA 唯一摯保 (AOACS)	
口服藥物 無需手術	
對治療有良好反應	
最後徵狀出現於兩年之內	人壽保障: +25% 原位癌及癌症保障: +25% 起
最後徵狀出現超過兩年	標準
對治療的反應不好，頻繁復發：	
最後徵狀出現於兩年之內	人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: +50% 起
最後徵狀出現超過兩年	標準
曾接受手術 完全康復 無徵狀	
全胃切除術及胃出口梗阻手術以外的所有手術，無復發	標準
因良性潰瘍進行全胃切除術	人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: +50% 起

備註：以上核保指引不包括持續使用非類固醇類消炎藥或皮質類固醇的情況，傾食症候群，卓-艾二氏綜合徵及酒精引起的消化性潰瘍
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

胃食道反流 (GERD)

簡介：胃食道括約肌不能正常關閉，導致胃內容物反流入食道

徵狀：消化不良；胃灼熱；噁心和非心源性胸痛

成因

- 肥胖；年齡增加；吸煙；酒精；食道裂孔疝；妊娠和硬皮病

治療

- 口服藥物
- 改變生活方式 (例如：戒煙，戒酒等)

核保要求

- 如曾接受胃鏡檢查及/或活組織檢查，須遞交報告
- 如情況嚴重，須索取主診醫生報告

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摺保 (AOACS)
沒有併發症，輕微症狀 (例如心口灼熱，消化不良)，無需作進一步檢查， 沒有吞嚥困難或咳血， 或體重下降	標準					

妊娠糖尿病

簡介：懷孕前沒有糖尿病病史，但在懷孕時卻出現高血糖的現象

徵狀：經常口渴; 尿頻; 手脚麻痺

治療

- 飲食控制

併發症

- 自然流產、早產、子癰前症

診斷標準

- 空腹血糖 (FBS) ≥ 7.0 mmol/l
或
- 葡萄糖耐量兩小時測試 ≥ 11.1 mmol/l
或
- 糖化血紅蛋白 (HbA1c) $\geq 6.5\%$

妊娠糖尿病



核保要求

- 體檢
- 驗血 (類別N) 及 驗血 (類別M) - 空腹 最少6 小時
- 顯微鏡尿液分析 (MU)
- 主診醫生報告(APS) (如需要)

核保指引

人壽/癌症全方位	危疾 / 早期危疾	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
核保決定取決於體檢和檢查報告的結果			

血尿症

簡介：尿液中有血液存在
徵狀：無症狀；排尿時疼痛
位置：泌尿生殖系統

成因

- 月經；創傷；性活動；腎臟感染；尿道癌；損傷；結核病；血管炎；系統性紅斑狼瘡(**SLE**)；多囊腎；腎或輸尿管結石；膀胱息肉 / 腫瘤；前列腺癌；前列腺腫大；高血壓；出血性疾病

治療

- 口服藥物；藥物注射；手術

血尿症



風險分類

血尿程度	Hemastix 試紙	顯微鏡尿液分析 (紅血球 (RBC) /HPF)
微量	邊緣顏色變化	1-4
輕度	+	5-9
中度	++	10-19
嚴重	≥ +++	≥ 20

核保要求

- 如血尿屬微量或輕度，需再進行一次顯微鏡尿液分析*
- 如血尿屬中度或嚴重，須於不同日期再進行兩次顯微鏡尿液分析及驗血 (類別B)
- 如曾接受檢查，須遞交所有報告 (包括顯微鏡尿液分析、腎功能測試、磁力共振、超聲波等)
- 如血尿屬中度或嚴重程度及需定期覆診或治療，或須索取主診醫生報告

* 備註：如為女性，顯微鏡尿液分析應於月經後 1 星期才可進行

血尿症



核保指引

年齡	血尿的程度	人壽	危疾 / 早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院
少於55	微量	標準			
	輕度	標準	危疾: 50% 早期危疾: 不保尿道原位癌*	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 不保尿道原位癌*	標準
	中度	50%	擱置受保		不保生殖及 泌尿系統
	嚴重	+100% 起	擱置受保		擱置受保
超過55	微量	標準	擱置受保		標準
	輕度	50%	擱置受保		
	中度 / 嚴重	擱置受保			
伴有其他泌尿系統異常，如蛋白尿 / 微量白蛋白尿:					
所有案例		個別考慮	擱置受保		

* 男性客人，早期危疾也不保早期前列腺癌

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

血尿症



風險分類

血尿的程度	癌症全方位
微量	標準
輕度	不保尿道原位癌及泌尿道癌
中度 / 嚴重	擱置受保

甲型肝炎

簡介：肝臟急性發炎

徵狀：發熱；食慾不振；肝臟腫大；黃疸；關節疼痛

甲型肝炎



成因

- 進食及飲用受污染的水和食物

治療

- 根據症狀治療

乙型肝炎

簡介：肝臟受病毒感染發炎

徵狀：全身乏力；食慾不振；噁心；腹痛；輕微發燒

乙型肝炎



成因

- 輸血；經由靜脈注射毒品；同性戀者；妓女；醫護人員；接受血液產品受贈人士

治療

- 臥床休息；避免肝毒性物質 (酒精、藥物)；疫苗；藥物治療；注射

甲型肝炎及乙型肝炎



核保要求

- 甲型肝炎：清楚詳述健康狀況：發病日期；檢查內容及結果；曾接受的治療；及目前狀況
- 急性乙型肝炎: HBsAg (如屬陽性，核保要求請依照慢性乙型肝炎)
- 慢性乙型肝炎(乙型肝炎帶菌者)
 - 沒有病發，治療或跟進: 驗血 (類別J)，驗血(類別G)
- 慢性乙型肝炎(乙型肝炎帶菌者)
 - 正在 / 結束接受抗病毒治療或跟進：
 - 1.驗血 (類別J)，驗血 (類別G)
 - 2.清楚詳述是否已停止治療及治療多久
 - 3.須索取主診醫生報告如果未能提供，請清楚詳述服用抗病毒藥物的原因，治療期和目前狀況及遞交肝臟超聲波報告。

甲型肝炎及乙型肝炎



核保指引 僅適合成人使用:

• 甲型肝炎：

人壽	完全康復距今的三個月內 - 延期
	完全臨床康復，肝功能指數正常 - 標準
危疾/ 早期危疾/ 癌症全方位	完全康復距今的三個月內 - 延期
	完全臨床康復，肝功能指數正常 - 標準
住院	完全康復距今的六個月內 - 延期
	完全臨床康復，肝功能指數正常 - 標準
AIA 唯一摺保 (AOACS)	完全康復距今的三個月內 - 延期
	完全臨床康復，肝功能指數正常 - 標準

• 急性乙型肝炎：

人壽	完全康復距今的六個月內 - 延期
	完全臨床康復，HBsAg為陰性- 標準
危疾/ 早期危疾/ 癌症全方位	完全康復距今的六個月內 - 延期
	完全臨床康復，HBsAg為陰性- 標準
住院	完全康復距今的六個月內 - 延期
	完全臨床康復，HBsAg為陰性- 標準
AIA 唯一摺保 (AOACS)	完全康復距今的六個月內 - 延期
	完全臨床康復，HBsAg為陰性- 標準

甲型肝炎及乙型肝炎



核保指引

僅適合成人使用:

- 慢性乙型肝炎(乙型肝炎帶菌者)
 - 沒有病發，治療或跟進
 - 如乙型肝炎E抗原陰性及視乎肝功能指數結果：

	人壽	危疾/ 早期危疾/ 癌症全方位	住院	AIA 唯一摺保 (AOACS)
確診於六個月內	自確診起，擱置受保六個月			
慢性乙型肝炎 (乙型肝炎帶菌者)	標準 如肝功能指數正常	標準如肝功能指數正常，否則+25% 起	+25% 起或不保*	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 標準如肝功能指數正常，否則+25% 起

- 慢性乙型肝炎(乙型肝炎帶菌者)
 - 正在接受抗病毒治療或跟進
 - 視乎肝功能指數結果及乙型肝炎E抗原狀態

人壽	危疾/ 早期危疾	AIA 唯一摺保 (AOACS)	癌症全方位	住院
+100% 以上	+125%以上 早期危疾:不保肝炎連肝硬化	拒絕受保		個別考慮

* 備註 = 不保肝臟 (包括肝硬化和肝癌)、膽道系統、乙型肝炎或其併發症

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

高膽固醇血症 / 高三酸甘油脂血症

簡介：血液中膽固醇水平過高；導致心血管疾病的主要因素

徵狀：無症狀

位置：血管

高膽固醇血症 / 高三酸甘油脂血症



成因

- 遺傳異常；年齡；性別；肥胖；飲食習慣；痛風；高血壓；糖尿病

治療

- 改變飲食習慣；運動及控制體重；降脂藥物

高膽固醇血症 / 高三酸甘油脂血症



定義

1. 膽固醇

- 存在於血液和身體組織中的脂肪狀物質

2. 低密度脂蛋白 (LDL)

- 把膽固醇從肝臟運送到身體各組織
- 低密度脂蛋白因此被視為是“壞”膽固醇

總膽固醇 (mmol/l)	低密度脂蛋白 (mmol/l)	詮釋
≤ 3.2	≤ 2.2	低膽固醇血症
3.21 - 5.2	2.21 - 3.36	理想
> 5.2	> 3.36	高膽固醇血症及心血管疾病風險增加

3. 高密度脂蛋白 (HDL)

- 把膽固醇從身體各組織運送到肝臟，使膽汁可消除膽固醇
- 高密度脂蛋白因此被視為是“好”膽固醇

高密度脂蛋白 (mmol/l)	詮釋
< 1.0	心血管疾病風險增加
1.0 - 1.55	正常
1.56 - 2.34	良好
> 2.34	非常良好

4. 三酸甘油脂

- 脂肪存於體內的主要形式，作為其他類型血脂的主要組成部分
- 高三酸甘油脂會令血管收窄

三酸甘油脂(mmol/l)	詮釋
≤ 2.2	正常
2.3 - 3.3	輕度高三酸甘油脂血症
3.4 - 5.6	中度高三酸甘油脂血症
5.7 - 11.2	顯著高三酸甘油脂血症
> 11.2	嚴重高三酸甘油脂血症

高膽固醇血症 / 高三酸甘油脂血症



核保要求

- 驗血 (類別M) (空腹6小時)

核保指引

- 保費評級視乎總膽固醇；高密度脂蛋白及三酸甘油脂的血液測試結果
- 還需要考慮血壓；體重；吸煙習慣等

高血壓

簡介：血壓持續上升，高於標準水平

徵狀：無症狀而臨床病徵通常只是血壓上升

世界衛生組織 (WHO) 對高血壓之定義

	收縮壓 (上壓)	舒張壓 (下壓)
理想	< 120	< 80
正常	120 – 129	80 – 84
血壓偏高	130 – 139	85 – 89
高血壓	≥ 140	≥ 90

成因

- 肥胖；高血脂；繼發於其他病症，如腎病、甲狀腺功能亢進、糖尿病及年老等；原因不明

治療

- 降血壓藥
- 針對成因治療

核保要求

- 體檢
- 靜態心電圖 (ECG) – 視乎年齡、患高血壓年期等

核保指引

- 保費評級視乎血壓讀數、整體情況如年齡、體重、吸煙習慣等
- 血壓 < 140 / 90，無其他心血管風險因素*

人壽 / 癌症全方位	標準
危疾 / 早期危疾	標準
住院	標準
AIA 唯一摺保 (AOACS)	標準

* 備註：心血管風險因素：例如 吸煙習慣，過重，高血壓，糖尿病，血脂異常等。

高尿酸血症（痛風）

簡介：尿酸水平過高是腎臟生成尿酸增加或排泄尿酸減少的結果

徵狀：無徵狀；關節劇痛；關節腫脹；關節畸形

高尿酸血症（痛風）

成因

- 尿酸鹽在關節部位的沉積
- 通過腎臟降低尿酸鹽排泄

治療

- 口服藥物

高尿酸血症（痛風）



核保要求

- 驗血 (類別Y) – 尿酸（如有需要）
- 需確認現時狀況，治療的方法，是否需要復診以及最後復診日期, 發作次數和頻率

核保指引

		人壽	危疾 / 早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摯保 (AOACS)
高尿酸血症（痛風），無徵狀		標準	標準	標準	標準	標準
原發性臨床痛風或痛風性關節炎無並發症(如高血壓,白蛋白尿或腎結石)	輕度	標準	標準	標準	標準	標準
	中度	標準	+50%起*	每年病發少於三次； -單關節：+25%或不保痛風 -多關節：+50%或不保痛風	標準	標準
	嚴重	標準至+75%*	+100%	不保痛風	標準至+75%*	人壽保障: 標準至+75%* 原位癌及癌症保障: 標準

備註：

* 核保結果將會根據驗血 (類別Y) – 尿酸測試結果和檢查報告而作評估



靈活核保決定

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

腸道疾病

結腸息肉

簡介：小簇的病變，突出到腸腔的表面，稱為息肉

徵狀：無症狀；腹痛；便血；排便習慣轉變

注意：本節不包括“家族性腺瘤性息肉”(FAP)

結腸息肉



成因

- 老化；家族史；生活方式的風險因素例如吸煙，飲食和肥胖等

治療

- 醫學觀察
- 手術切除

核保要求

- 遞交所有檢查報告如腸鏡檢查；包括切除結腸息肉後進行的任何腸鏡檢查（如有）
- 如曾接受手術，須遞交病理報告
- 如沒有病理報告，須填交腫瘤 / 囊腫問卷
- 如情況嚴重或不能提供病理報告，須索取主診醫生報告

結腸息肉



核保指引

風險分類		人壽	危疾	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)
已做切除手術及 病理報告確定為良性		標準	根據結腸息肉的性質及 數量而定標準；或不保 大腸癌	根據結腸息肉的性質及數 量而定標準；或不保結腸 原位癌及/或直腸原位癌	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 根據結腸息肉的性質 及數量而定標準；或 不保大腸癌及結腸原 位癌及/或直腸原位癌
已做切除手術 原位癌/高度細 胞病變	已完全任何手術, 放射治療及化學 治療≤2年	≤1年: +\$5/M x 3年 1-2年: +\$5/M x 2年	擱置受保		
	已完全任何手術, 放射治療及化學 治療>2年	標準	不保大腸癌	不保結腸原位癌及/或直腸 原位癌	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 不保大腸癌及結腸原 位癌及/或直腸原位癌
沒有切除手術, 定期觀察		個別考慮			

核保指引

風險分類	住院	癌症全方位
已做切除手術及 病理報告確定為良性	如性質為增生性、少年性、化生性或 缺陷瘤：標準 否則，不保結腸及直腸	根據結腸息肉的性質及數量而定 標準；或 不保結腸原位癌及/或直腸原位癌及/或 大腸癌
已做切除手術 原位癌/高度細胞病變	已完全任何手術, 放射治療及化學治 療≤2年：擱置受保 已完全任何手術, 放射治療及化學治 療>2年：不保結腸及直腸	不保結腸原位癌及/或直腸原位癌及/或 大腸癌
沒有切除手術, 定期觀察	擱置受保	不保結腸原位癌及/或直腸原位癌及/或 大腸癌

腸道疾病

痔瘡

簡介：直腸末端，無論肛門括約肌上 (內痔) 或下 (外痔) 的靜脈曲張
稱為痔瘡

症狀：肛門搔癢；便血

痔瘡



成因

- 最常見的原因是排便不規律

治療

- 外用藥物
- 情況嚴重可能需要做手術

核保要求

- 治療種類
- 最後一次病發日期

核保指引

	人壽	危疾	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院	癌症全方位
痔瘡仍在	標準				不保痔瘡	標準
手術治療後完全康復	標準				手術後一年內，不保痔瘡 其後標準	標準

川崎病

簡介: 病徵普遍發生於五歲以下兒童, 造成罕見的全身各個器官的血管發炎

徵狀: 發熱, 結膜炎, 頸部淋巴結腫大, 皮疹和腳/手腫脹, 有可能引致冠狀動脈/血管發炎形成動脈瘤

川崎病



成因

- 血管發炎

治療

- 靜脈注射免疫球蛋白和阿司匹林

核保要求

- 主診醫生報告
- 遞交所有檢查報告如超聲心動圖

核保指引 (兒童)

	人壽	危疾	住院	癌症全方位
未確診	擱置受保	擱置受保	通常拒絕受保	擱置受保
有完整檢察記錄， 若發病時、痊癒後 及發病後一年的超 聲心動圖證明冠狀 動脈正常	十二個月內仍有症 狀擱置受保及其後 標準	十二個月內仍有症 狀擱置受保及其後 標準	個別考慮	十二個月內仍有症 狀擱置受保及其後 標準
若曾有或仍有冠狀 動脈異常	個別考慮	拒絕受保	拒絕受保	個別考慮

核保指引 (兒童)

條件	早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)
1)未確診		
A) 距離最後一次的症狀（月）		
<12	擱置受保	
>12	+50%	人壽保障: +\$1/M 原位癌及癌症保障: +25%
B) 最近三年無症狀	標準	
2)有完整檢察記錄並確切診斷:		
A) 在任何時段無冠狀動脈異常:		
距離最後一次的症狀（月）:		
<12	擱置受保	
>12	標準	
B)現時心血管正常, 以前的一次或多次冠狀動脈擴張-動脈瘤或擴張	拒絕受保	個別考慮
C) 現時冠狀動脈異常	拒絕受保	個別考慮

精神障礙

焦慮症

簡介: 患者出現主觀情緒和各種軀體症狀例如肌肉緊張等植物神經狀

徵狀: 心跳加速; 呼吸急速; 胸悶; 腹痛; 頭暈等

焦慮症



成因

- 過度的壓力; 基因遺傳; 生理因素或心理因素; 濫用藥物

治療

- 藥物治療
- 心理治療

風險分類

特點	輕度	中度	嚴重
頻率	沒有心身反應的症狀	偶然	經常性或更深
治療	由私人醫生提供	由精神治療專家提供（只有門診）	由精神治療專家提供（可能需要入院）
不能工作	沒有	偶然	多於兩星期
行為異常的身體疾病	沒有	可能	有

焦慮症



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告

精神障礙

抑鬱症

簡介: 以心境障礙為特征的一類病, 表現為悲哀, 失望或無助等

徵狀: 情緒低落; 時常感到疲倦; 過份自卑或自責; 難於集中精神;
失眠; 有自殺念頭及身體症狀

抑鬱症



成因

- 基因遺傳; 生理因素或心理因素; 濫用藥物

治療

- 藥物治療
- 心理治療

風險分類

特點	輕度	中度	嚴重
頻率	沒有心身反應的症狀	偶然	經常性或更深
治療	由私人醫生提供	由精神治療專家提供（只有門診）	由精神治療專家提供（可能需要入院）
不能工作	沒有	偶然	多於兩星期
行為異常的身體疾病	沒有	可能	有

抑鬱症



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告

焦慮症 & 抑鬱症



核保指引 (僅適合成人使用)

病症	人壽	危疾/早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)
輕度抑鬱症，輕度抑鬱徵狀，廣場恐懼症，或恐慌症			
病情已康復或控制良好	標準	標準	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 標準
廣泛性焦慮症			
病情完全康復，距離上次病發和治療超過 5 年	考慮標準	考慮標準	人壽保障: 考慮標準 原位癌及癌症保障: 考慮標準
控制良好及症狀穩定，少於 5 年	如 ≥ 65 歲，標準 否則 +25%起**	如 ≥ 45 歲，標準 否則 +25%起**	人壽保障: 標準或加價取決於年齡** 原位癌及癌症保障: 標準
重度抑鬱症			
病情完全康復，距離上次病發和治療超過 5 年	考慮標準	考慮標準	人壽保障: 考慮標準 原位癌及癌症保障: 考慮標準
控制良好及症狀穩定，少於 5 年	取決於年齡，最少+25%**	如 ≥ 65 歲，標準 否則 +25%起**	人壽保障: 取決於年齡，最少+25%** 原位癌及癌症保障: 標準
雙極躁鬱症(躁狂抑鬱症)			
控制良好及症狀穩定，超過 5 年	取決於年齡，最少+25%**	如 ≥ 65 歲，標準 否則 +25%起**	人壽保障: 取決於年齡，最少+25%** 原位癌及癌症保障: 標準
控制良好及症狀穩定，少於 5 年	取決於年齡，最少+50%**	取決於年齡，最少 +25%**	人壽保障: 取決於年齡，最少+50%** 原位癌及癌症保障: 標準

備註:

最後決定取決於有無藥物濫用史，企圖自殺歷史，體重不足，任何其他精神疾病的組合，過往五年因精神障礙需要住院治療病史，并存身体健康受损可能會增加保費或拒絕受保

** 最終評級取決於受保人的年齡。受保人越年輕，評級越高

焦慮症 & 抑鬱症



核保指引 僅適合成人使用:

		住院	癌症全方位
1) 重度抑鬱症，雙極躁鬱症(躁狂抑鬱症)		拒絕受保	標準
2) 輕度抑鬱症，抑鬱症狀，普通焦慮症狀或障礙，恐慌症狀或病症			
a) 症狀持續		拒絕受保	標準
b) 已成病史，已無藥物治療和/或心理治療， 距離上次藥物治療的時間：	<1 年	擱置受保	標準
	1-5 年	個別考慮	標準
	>5 年	標準	標準

備註:

最後決定取決於有無藥物濫用史，企圖自殺歷史，體重不足，任何其他精神疾病的組合，過往五年因精神障礙需要住院治療病史，并存身體健康受損可能會增加保費或拒絕受保

新生兒黃疸

簡介：身體內膽紅素升高

徵狀：皮膚和眼睛變黃

成因

- 身體無法正常處理膽紅素
- 肝發炎
- 膽管阻塞
- 假性黃疸
- 嬰兒在出身的第一周，因非結合性的膽紅素升高而出現明顯的黃疸

治療

- 根據黃疸成因而治療

新生兒黃疸



核保要求

- 需確認現時狀況，治療的方法，是否需要覆診以及最後覆診日期
- 遞交所有檢查報告 (如有需要)
- 主診醫生報告 (如有需要)

核保指引

僅適合初生嬰兒使用:

	人壽	危疾/ 早期危疾	AIA 唯一摯保 (AOACS)	住院	癌症全方位
生理性黃疸，1個月內完全康復，症狀已緩解	標準				
現存疾病或非生理性黃疸	個別考慮*			拒絕受保	個別考慮*

備註：

* 最終決定視乎客戶目前的健康狀況及潛在病因

非瓣膜性心臟疾病

心房間隔缺損 (ASD)

簡介：先天性心房間隔缺損是指心房間隔出現一個或多個孔洞，輕微缺損的情況可能自動關閉

徵狀：容易疲勞; 心力衰竭; 心悸

位置：心臟

心房間隔缺損 (ASD)

成因

- 多數是先天性，通常是偶爾及獨立發生的

治療

- 藥物治療
- 手術治療

非瓣膜性心臟疾病

心室間隔缺損 (VSD)

簡介：心室間隔缺損是指心室間隔出現一個或多個孔洞, 輕微缺損可能自動關閉

徵狀：細小的心室間隔缺損可以無症狀, 嚴重缺損會出現生長發育緩慢; 氣喘, 反覆肺部感染和充血性心臟衰竭

位置：心臟

心室間隔缺損 (VSD)



成因

- 多數是先天性

治療

- 藥物治療
- 手術治療

心房/心室間隔缺損 (ASD/VSD)



風險分類:

心房/心室間隔缺損程度決定於超聲心動圖(心臟超聲波) (Echocardiogram)
微量
輕度
中度
嚴重

心房/心室間隔缺損 (ASD/VSD)

核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告
- 遞交所有檢查報告如最近的超聲心動圖(Echocardiogram)
- 心電圖(ECG)

心房/心室間隔缺損 (ASD/VSD)



核保指引 (ASD)

僅適合成人使用

風險分類		人壽		危疾/早期危疾		住院	癌症全方位
		年齡18-40	年齡>40	年齡18-40	年齡>40		
未做手術	微量	標準	標準	+50%	標準	不保心臟	標準
	輕度	+100%	+75% 60歲後考慮標準	拒絕受保	+100% 60歲後考慮標準	拒絕受保	標準
	中度	+150%	+50%起	擱置受保	擱置受保; 60歲後考慮+100%	拒絕受保	標準
	嚴重	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	標準
已做手術及 沒有併發症, 一年後超聲 心動圖證明無後遺症**		完成手術<6個月: 擱置受保 其後: 標準		完成手術<1年: 擱置受保 其後: 可考慮標準		完成手術<3年: 擱置受保 其後如果沒有不利特徵則 標準	標準
艾森曼格綜合徵, 接受 或未接受手術		拒絕受保		拒絕受保		拒絕受保	標準

備註:

**個別考慮併發症如心臟分流、肺靜脈高血壓、異常心電圖、心律不正或併存瓣膜疾病的個案

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

心房/心室間隔缺損 (ASD/VSD)

核保指引 (ASD)

僅適合成人使用

風險分類		AIA 唯一摯保 (AOACS)	
		年齡18-40	年齡>40
未做手術	微量	標準	
	輕度	人壽保障: +100% 原位癌及癌症保障: 標準	人壽保障: +75% 60歲後考慮標準 原位癌及癌症保障: 標準
	中度	拒絕受保	人壽保障: +50%起 原位癌及癌症保障: 標準
	嚴重	拒絕受保	
已做手術及 沒有併發症, 一年後超聲心動圖證明無後遺症**		完成手術<6個月: 擱置受保 其後: 標準	
艾森曼格綜合徵, 接受或未接受手術		拒絕受保	

備註:

**個別考慮併發症如心臟分流、肺靜脈高血壓、異常心電圖、心律不正或併存瓣膜疾病的個案

心房/心室間隔缺損 (ASD/VSD)



核保指引 (VSD)

僅適合成人使用

風險分類		人壽		危疾		住院	癌症全方位
		年齡18-40	年齡>40	年齡18-40	年齡>40		
未做手術	微量	+50%	標準	+75%	+50%	不保心臟	標準
	輕度	+50%	標準	拒絕受保	拒絕受保		
	中度	+100%	+50%	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	標準
	嚴重	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	拒絕受保	標準
已做手術及 沒有併發症，一年後超 聲心動圖證明無後遺 症**		完成手術<6個月：擱置受保 其後：標準		完成手術<6個月：擱置受保 其後：可考慮標準		完成手術<3年：擱置受保 其後如果沒有不利特徵則 標準	標準
艾森曼格綜合徵，接受或未接受手術		拒絕受保		拒絕受保		拒絕受保	標準

備註：

**個別考慮併發症如心臟分流、肺靜脈高血壓、異常心電圖、心律不正或併存瓣膜疾病的個案

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

心房/心室間隔缺損 (ASD/VSD)



核保指引 (VSD) 僅適合成人使用

風險分類		AIA 唯一摯保 (AOACS)	
		年齡18-40	年齡>40
未做手術	微量	人壽保障: +50%	標準
	輕度	原位癌及癌症保障: 標準	
	中度	人壽保障: +100% 原位癌及癌症保障: 標準	人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: 標準
	嚴重	拒絕受保	
已做手術及 沒有併發症, 一年後超聲心動圖證明無後遺症**		完成手術<6個月: 擱置受保 其後: 標準	
艾森曼格綜合徵, 接受或未接受手術		拒絕受保	

備註: **個別考慮併發症如心臟分流、肺靜脈高血壓、異常心電圖、心律不正或併存瓣膜疾病的個案

睡眠窒息症 (OSA)

簡介：睡眠呼吸紊亂 (SDB) 障礙

徵狀：白天嗜睡；打鼻鼾；焦躁不安；難以熟睡；疲倦；抑鬱；
高血壓

睡眠窒息症 (OSA)



成因

- 肥胖；上呼吸道軟組織異常；年老；遺傳；吸煙；飲酒；鼻塞；糖尿病；停經後雌激素不足

治療

- 減肥；避免飲酒及使用鎮靜劑；使用正壓呼吸輔助器 (CPAP)；懸雍垂顎咽整型手術；以外科手術改善呼吸道阻塞；口服藥物

睡眠窒息症 (OSA)



風險分類

	輕度	中度	嚴重
徵狀 / 對治療的反應	對治療反應良好，但仍會出現白天嗜睡	偶爾白天嗜睡	持續出現白天嗜睡徵狀
身體機能	沒有影響性格，工作或社交生活	沒有影響性格，工作或社交生活	明顯影響工作能力、並出現身體功能障礙，如焦慮和抑鬱
呼吸減弱指數 (AHI)或呼吸紊亂指數 (RDI)	少於15	15 - 30	高於 30
氧飽和度	一般超過 80%	在睡眠時低於80%，睡醒時能回到基本水平	可能低於 60%，在呼吸暫停之間可能出現長時間的缺氧

睡眠窒息症 (OSA)



核保要求

- 睡眠測試報告

核保指引

			人壽 / 癌症全方位	危疾 / 早期危疾	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
疑似症狀，但未經檢查			擱置受保直至檢查完成			
未有治療	輕度睡眠窒息症		標準		不保阻塞性睡眠窒息症*	標準
	中度睡眠窒息症		視乎於投保人的年齡，可能非標準保費		拒絕受保	人壽保障: 視乎於投保人的年齡，可能非標準保費 原位癌及癌症保障: 標準
	嚴重睡眠窒息症		視乎於投保人的年齡，+100% 起		拒絕受保	人壽保障: 視乎於投保人的年齡，+100% 起 原位癌及癌症保障: 標準
已接受治療或正在治療且適應(使用CPAP、下頷推進裝置、成功的手術矯正或治療後睡眠監測記錄顯示風險因素減少)	輕度睡眠窒息症#		標準		不保阻塞性睡眠窒息症*	標準
	中度睡眠窒息症#	良好的治療依從性，現在的風險分類為輕度				
		否則	視乎於投保人的年齡，可能非標準保費	拒絕受保	人壽保障: 視乎於投保人的年齡，可能非標準保費 原位癌及癌症保障: 標準	
	嚴重睡眠窒息症#		視乎於投保人的年齡，治療年期和治療後結果，一般為非標準保費	拒絕受保	人壽保障:視乎於投保人的年齡，治療年期和治療後結果，一般為非標準保費 原位癌及癌症保障: 標準	
慢性阻塞性肺病			個別考慮		拒絕受保	個別考慮

備註：* 如受保人擁有其他心血管風險因素，可能拒絕受保
指初次診斷

中耳炎

簡介 : 中耳發炎疾病

徵狀 : 耳朵疼痛； 聽力喪失

中耳炎



成因

- 中耳受到細菌或病毒感染

治療

- 抗生素

中耳炎(成人)



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告

核保指引

成人		人壽	危疾 / 早期危疾	AIA 唯一摺保 (AOACS)	住院	癌症全方位
急性中耳炎，通過 抗生素成功治療， 沒有嚴重後遺症， 聽力受損或失聰後 遺症	單次急性發病	標準			最後徵狀出現超過三個月， 標準 最後徵狀出現少於或等於 三個月，不保任何左耳/右 耳疾病、包括失聰或+25% 	標準
	多次發病	標準			最後徵狀出現超過三年， 標準 最後徵狀出現少於或等於 三年，不保任何左耳/右耳 疾病、包括失聰或+25% 	標準
否則		個別考慮*				

備註：

* 核保結果將會根據主診醫生報告和病理報告而作評估



靈活核保決定

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

中耳炎(兒童)



核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告

核保指引

兒童			人壽	危疾 / 早期危疾	AIA 唯一摺保 (AOACS)	住院	癌症全方位
急性中耳炎，通過抗生素成功治療，沒有嚴重後遺症，聽力受損或失聰後遺症	單次急性發病	最後徵狀出現超過三個月	標準			標準	標準
		最後徵狀出現少於或等於三個月	標準			年齡 ≤ 12; ##留置權: 不保任何左耳/右耳疾病、包括失聰，賠償比率如下： 等候期 賠償比率 首六個月: 0% 第七個月或以後: 100% 年齡 > 12; 不保任何左耳/右耳疾病、包括失聰	標準
	多次發病	最後徵狀出現超過三年	標準			標準	標準
		最後徵狀出現少於或等於三年	標準			年齡 ≤ 12; ##留置權: 不保任何左耳/右耳疾病、包括失聰，賠償比率如下： 等候期 賠償比率 首年: 0% 第二年: 50% 第三年或以後: 100% 年齡 > 12; 不保 任何左耳/右耳疾病、包括失聰	標準
否則			個別考慮*				

備註：

* 核保結果將會根據主診醫生報告和病理報告而作評估



靈活核保決定

##留置權法不適用於自願醫保產品

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

過重

簡介：脂肪積聚過多，可能會損害健康

徵狀：無症狀

身體質量指數 (BMI) 表



BMI (僅適合成人使用)	分類
< 18.5	過輕
18.5 – 24.9	正常
25.0 – 29.9	過重
30.0 – 34.9	肥胖 第一級
35.0 – 39.9	肥胖 第二級
≥ 40.0	肥胖 第三級

BMI (體重指數) 公式 = $\frac{\text{體重 (公斤)}}{\text{身高 (米)}^2}$

* 資料來源: 世界衛生組織 (WHO)

過重



成因

- 過量進食

治療

- 控制飲食；運動；胃繞道手術

核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告 (如曾已做手術)

核保指引

- 保費評級視乎身體質量指數 (BMI)、年齡、性別、吸煙習慣及種族以及/或血壓和其他心血管風險因素*

* 備註：心血管風險因素：例如 吸菸習慣, 過重, 高血壓, 糖尿病, 血脂異常等

垂體疾病

泌乳素瘤

簡介: 腦下垂體的良性腫瘤 (腺瘤), 它能生產催乳素

徵狀: 荷爾蒙失調; 頭痛; 視覺障礙

垂體疾病

高催乳素血症

簡介: 血液中催乳激素水平高於相同年齡和性別的人群

徵狀: 女士 - 閉經; 不育; 乳溢
男士 - 陽痿; 有時候乳溢

泌乳素瘤 & 高催乳素血症



成因

- 可能是生理（例如懷孕，壓力），病理（例如, 垂體瘤）或藥物引起
- 垂體瘤患者可能會出現激素生產過剩，造成高催乳素血症

治療

- 醫學觀察
- 荷爾蒙治療
- 手術

核保要求:

- 體檢
- 血清泌乳素水平
- 遞交所有檢查報告如腦磁力共振
- 如曾接受手術，須遞交病理報告
- 主診醫生報告

泌乳素瘤 & 高催乳素血症



核保指引 僅適合成人使用:

		人壽	危疾	早期危疾	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)	癌症全方位
高催乳素血症, 沒有找到原因或未切除微腺瘤/泌乳素瘤(≤ 10mm)，垂體窩正常, 沒有皮質類固醇替代治療		標準		不保腦下垂體腫瘤切除手術和單眼失明	不保垂體	標準	若距手術在三年之內則擱置受保, 其後 個別考慮
皮質類固醇替代治療的後遺垂體機能減退						個別考慮	
腺瘤/泌乳素瘤 (>10mm)/大腺瘤 手術性治療， 完全康復並沒有併發症及沒有復發	治療後康復 ≤6個月	擱置受保					
	治療後康復 > 6個月	標準		若病史在三年之內不保垂體 及 其後標準	標準		

早產兒

簡介：37週之前出生的嬰兒被定義為早產

徵狀：出生體重過輕；聽力和視力損害；先天性異常；神經系統及呼吸系統問題

成因

- 健康胎兒的併發症;產婦的健康狀況及受創傷

治療

- 如果出生體重嚴重過輕需要延續醫院治療
- 視乎不同併發症程度而作出治療

早產兒



風險分類

分類	體重(gm)
正常	> 2500
出生體重過輕	1500 - 2500
出生體重嚴重過輕	< 1500
胎兒宮內發育遲緩	視乎早產兒程度

核保要求

- 體檢
- 主診醫生報告
- 出院摘要/ 兒童健康記錄

核保指引

風險分類	人壽/危疾/早期危疾/住院/癌症全方位/AIA 唯一摺保系列 (AOACS)
出生體重過輕	
1500 - 2500g	擱置受保至出生12個月後，再根據當時健康狀況個別考慮
出生體重嚴重過輕	
751 - 1499g	擱置受保至2歲後，再根據當時健康狀況個別考慮
$\leq 750g$	擱置受保至4歲後，再根據當時健康狀況個別考慮
胎兒宮內發育遲緩	
出生體重 $> 1500g$	擱置受保至3歲後，再根據當時健康狀況個別考慮
出生體重 $\leq 1500g$	擱置受保至4歲後，再根據當時健康狀況個別考慮

備註:

* 最後等級取決於小孩的發展里程碑, 任何併發症或後遺症

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

蛋白尿症

簡介：尿液中蛋白質過量
徵狀：水腫及低血清白蛋白
位置：泌尿生殖系統

蛋白尿症



成因

- 腎病；膀胱疾病；腫瘤；高血壓；糖尿病或尿液受陰道分泌污染

治療

- 口服藥物

風險分類

蛋白尿程度	定性測量 (試紙)
輕度	+
中度	++
顯著 / 腎病綜合症	≥ ++

核保要求

- 如蛋白尿屬微量或輕度，需再進行一次顯微鏡尿液分析*
- 如蛋白尿屬中度或顯著，須於不同日期再進行兩次顯微鏡尿液分析*
- 驗血 (類別B)
- 如曾接受檢查，須遞交所有報告 (包括顯微鏡尿液分析、腎功能測試、磁力共振、超聲波等)
- 如蛋白尿屬中度至顯著及需定期覆診，或須索取主診醫生報告

* 備註：如為女性，顯微鏡尿液分析應於月經後 1 星期才可進行

蛋白尿症



核保指引

僅適合成人使用：

蛋白尿程度		人壽 / 癌症全方位	危疾 / 早期危疾	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
腎小球濾 過率 (血清 肌酐結果) 未知	微量	標準			
	輕度	+100%	+100%	不保 泌尿生殖系統	人壽保障: +100% 原位癌及癌症保 障: 標準
	中度	+150%	擱置受保		
	顯著 / 腎病 綜合症	擱置受保			

* 備註: 以上表格以沒有糖尿病、心血管疾病、高血壓或其他尿液異常為前提

前列腺特異抗原(PSA)異常

簡介: 前列腺特異抗原 (PSA) 是一種用於篩選前列腺癌的腫瘤指標

徵狀: 排尿困難(例如: 尿流緩慢或中斷) ; 尿頻

前列腺特異抗原(PSA)異常



成因

- 前列腺增生，發生在老年男性和良性前列腺肥大（BPH）以及前列腺癌

治療

- 手術切除
- 藥物治療
- 醫學觀察

前列腺特異抗原(PSA)異常

核保要求

- 最近六個月內之前列腺超聲波報告
- 驗血 (類別Y) : 前列腺特異抗原
- 顯微鏡尿液分析
- 病理報告 (如已做切除手術)

核保指引

		人壽	危疾	早期危疾	住院
目前正在檢查中		擱置受保至全面檢測			
沒有活檢; 沒有治療	PSA* ≤ 2.50 ng/mL	標準	標準	標準	一般為擱置受保，視乎於受保人的年齡及PSA* 測試結果
	PSA* 2.51-4.00 ng/mL	年齡 < 50，+50% 年齡 ≥ 50，標準	年齡 < 50，不保前列腺癌 年齡 ≥ 50，標準	年齡 < 50，不保早期前列腺癌 年齡 ≥ 50，標準	
	PSA* 4.01-10.00 ng/mL	非標準保費，視乎於受保人的年齡及PSA* 測試結果	不保前列腺癌	不保早期前列腺癌	
	PSA* 10.00 to 15.00 ng/mL	年齡 < 60，擱置受保 年齡 ≥ 60，+50%起	年齡 < 60，擱置受保 年齡 ≥ 60，不保前列腺癌	年齡 < 60，擱置受保 年齡 ≥ 60，不保早期前列腺癌	
	PSA* > 15.00 ng/mL	擱置受保	擱置受保	擱置受保	

* 備註 : 前列腺特異抗原
AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.
[AIA – INTERNAL]

前列腺特異抗原(PSA)異常

核保指引

			AIA 唯一摯保 (AOACS)
目前正在檢查中			擱置受保至全面檢測
沒有活檢; 沒有治療	PSA* ≤ 2.50 ng/mL		標準
	PSA* 2.51-4.00 ng/mL	年齡 < 50	人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: 不保早期前列腺癌及前列腺癌
		年齡 ≥ 50	標準
	PSA* 4.01-10.00 ng/mL		人壽保障: 非標準保費，視乎於受保人的年齡及 PSA* 測試結果 原位癌及癌症保障: 不保早期前列腺癌及前列腺癌
	PSA* 10.00 to 15.00 ng/mL		拒絕受保
	PSA* > 15.00 ng/mL		拒絕受保

* 備註 :前列腺特異抗原

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

前列腺特異抗原(PSA)異常



核保指引

		癌症全方位
不正常的PSA* 及良性前列腺增生		擱置受保至全面檢測
只有PSA*上升	PSA* < 10 ng/mL	不保早期前列腺癌及前列腺癌
	PSA* ≥ 10ng/mL	擱置受保

* 備註 :前列腺特異抗原

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

前列腺特異抗原(PSA)異常

「多重智倍保」良性病變賠償 核保要求

- 過往的前列腺超聲波報告
- 於六個月內在#首選的化驗所進行的前列腺超聲波報告及符合所需內容*
- 前列腺特異抗原(PSA)水平測試
- 主診醫生報告(APS) (如需要)

* 前列腺超聲波報告應包括:

- 迴聲
- 包膜情況
- 前列腺大小
- 前列腺體積
- 精囊影像所見

有關首選的化驗所的詳情，請參閱附錄丙

前列腺特異抗原(PSA)異常

「多重智倍保」良性病變賠償

	良性病變賠償
- 等待進行進一步的檢查，活體組織檢查或外科手術 - 不正常的PSA*及良性前列腺增生	擱置受保至全面檢測
- 沒有任何疑似惡性情況 - 沒有2個或以上的直系親屬在60歲以前患有前列腺癌的家族史 - 年齡 < 60 - PSA* < 10 ng/mL, 或 年齡 ≥ 60 - PSA* < 13 ng/ml	為早期前列腺癌,前列腺原位癌及前列腺癌提供相等於20%原有保額的良性疾病保障

* 備註 :前列腺特異抗原

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

肺結節

簡介：肺部結節通常為局部，圓形或不規則，不透明，可能良好或不明確的病變

徵狀：通常為沒有重大徵狀及偶然發現

成因

- 腫瘤(良性或惡性): 肺癌, 來自不同部位之轉移, 淋巴瘤, 纖維瘤, 神經纖維瘤等
- 發炎及感染性疾病: 結核, 肺炎等
- 其他原因: 結節性多發性動脈炎、肺膿瘍、類風濕性關節炎等

治療

- 具有典型良性特徵的肺結節, 例如-兩年內穩定, 低風險的良性鈣化, 通常不需要任何進一步的檢查.
- 提示有惡性病變通常會被轉介作進一步評估或覆診.

核保要求

- 最新及之前之胸部CT報告
- 發現結節的時間
- 活檢結果(如有)

免責聲明：

此核保指引僅適用於透過 CT 掃描發現的無症狀、偶然發現的單一或多個肺結節。

對於多個肺結節，應以最嚴重的結節作為評估的依據。

在排查潛在症狀期間發現的肺結節，則擱置受保至作出全面評估後再決定評級。

風險因素

條件	低風險 - 受保人需要滿足以下所有條件:	高風險 - 受保人有以下其中一項條件:
吸煙史	非吸煙者或戒煙5 年或以上	吸煙者或戒煙不超過5年
結節位置	肺結節沒有涉及肺上葉	肺結節涉及肺上葉
結節邊緣	結節邊緣沒有任何不規則或異常	結節邊緣形狀不規則或異常
肺癌家族史	直系親屬無肺癌家族史	直系親屬有肺癌家族史
癌症病史	無	有
接觸有害化學物質	從未接觸過有害化學物質	曾接觸過有害化學物質

肺結節



核保指引 實性肺結節 (低風險)

結節大小:	受保人歲數:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
< 4 mm	≤ 50	< 1年	標準	標準 (備註*)	不保肺
		≥ 1年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺
	> 50	< 1年	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
		≥ 1年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

肺結節



核保指引 實性肺結節 (低風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
≥ 4 - ≤ 6 mm	< 1年	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	≥ 1 - < 2年及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	≥ 2年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

肺結節



核保指引 實性肺結節 (低風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間 :	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
> 6 - ≤8 mm	< 1.5年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	≤ 1.5年及穩定 (備註*)	+ 50 起	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	> 1.5年及穩定 (備註*#)	標準	標準	不保肺
> 8mm	≤ 2年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 2 - ≤ 3年及穩定 (備註*)	+ 100 起	不保肺癌及肺原位癌	個別考慮
	> 3 - < 5年及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	≥ 5年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

對於癌症全方位和其他危疾產品(愛伴航除外), 結節發現時間1.5至2年且穩定的情況, 個案需諮詢產品所屬再保險公司的意見。標準核保決定需符合結節發現時間超過2年且穩定的條件。

肺結節



核保指引 實性肺結節 (高風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
≤ 4 mm	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6 - ≤ 12個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	擱置受保
	> 1 - < 5年及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	≥ 5年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺
>4 - ≤ 6 mm	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6 - ≤ 12個月及穩定 (備註*)	+ 50 起	不保肺癌及肺原位癌	擱置受保
	> 1 - < 5年及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	≥ 5年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

肺結節



核保指引 實性肺結節 (高風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
> 6 - ≤ 8 mm	≤ 1年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 1 - ≤ 2年及穩定 (備註*)	+ 100 起	不保肺癌及肺原位癌	擱置受保
	> 2 - < 5年及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	≥ 5年及穩定 (備註*)	標準	標準	不保肺
> 8 mm	≤ 3年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 3年及穩定 (備註*)	個別考慮	擱置受保	個別考慮

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

個別考慮:個案需諮詢產品所屬再保險公司的意見。

肺結節



核保指引

半實性 (包括磨玻璃)肺結節 (低風險)

結節大小:	受保人歲數:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
< 4 mm	≤ 45	< 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
		≥ 6個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	> 45	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
		> 6 - 12個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	擱置受保
		> 12個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

肺結節



核保指引 半實性 (包括磨玻璃)肺結節 (低風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
≥ 4 – ≤ 6mm	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6 - 12個月及穩定 (備註*)	標準 #	不保肺癌及肺原位癌	擱置受保
	> 12個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

對於樂怡人生系列和其他人壽產品, 至少 + 50 起。

肺結節



核保指引 半實性 (包括磨玻璃)肺結節 (低風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間 :	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
> 6 - ≤ 8 mm	≤ 1年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 1年及穩定 (備註*)	+ 50 起	不保肺癌及肺原位癌	個別考慮
> 8 mm	≤ 3年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 3年及穩定 (備註*)	個別考慮	個別考慮	個別考慮

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

個別考慮:個案需諮詢產品所屬再保險公司的意見。

肺結節



核保指引 半實性 (包括磨玻璃)肺結節 (高風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
< 4 mm	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6 - 12個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌 *如結節無可疑特徵/惡性腫瘤的特徵 否則擱置受保	擱置受保
	> 12個月及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

肺結節

核保指引 半實性 (包括磨玻璃)肺結節 (高風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間:	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
≥ 4 - ≤6mm	≤ 6個月	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 6 - 12個月及穩定 (備註*)	+ 75 起	不保肺癌及肺原位癌 *如結節無可疑特徵/惡性腫瘤的特徵 否則擱置受保	擱置受保
	> 1 - ≤ 5 年及穩定 (備註*)	+ 50 起	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
	> 5 年及穩定 (備註*)	標準	不保肺癌及肺原位癌	不保肺

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

肺結節



核保指引 半實性 (包括磨玻璃)肺結節 (高風險)

結節大小:	自初次診斷以來的時間 :	人壽	危疾/早期危疾/癌症全方位	醫療
> 6 - ≤ 8 mm	≤ 3 年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 3 年及穩定 (備註*)	+ 50 起	不保肺癌及肺原位癌	不保肺
> 8 mm	≤ 5 年	擱置受保	擱置受保	擱置受保
	> 5 年及穩定 (備註*)	個別考慮	擱置受保	個別考慮

備註*:至少2份肺部電腦掃描報告顯示情況穩定(形狀、大小及數量沒有轉變)及無需跟進, 2份報告相隔至少6個月, 以及最近期的電腦掃描報告需要在半年內, 否則擱置受保。

個別考慮:個案需諮詢產品所屬再保險公司的意見。

泌尿系統疾病

腎石

簡介：尿液中的礦物質結晶沈積在腎臟或輸尿管

徵狀：無症狀；腰痛或疼痛伸延至下腹部和腹股溝；血尿

成因

- 脫水; 代謝異常; 尿道炎等

治療

- 隨尿液自行排出體外
- 非侵入性治療，例如：體外震波碎石術治療
- 侵入性治療，例如：內視鏡
- 手術治療

核保要求

- 顯微鏡尿液分析(MU), 如有須要
- 遞交所有有關檢查報告(包括腎功能測試、靜脈腎盂造影、X光報告等)
- 需要詳述病發日期, 最後病發, 治療, 及目前的狀況

核保指引

		人壽	危疾	早期危疾	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
已治療，無結石存在，完全治癒， 無後遺症，腎功能沒有受損，沒有 併發症及無需長期藥物治療	單邊結石	標準	**如最後徵狀出現 超過一年，標準	如最後徵狀出現 超過兩年，標準	單次發病: 最後徵狀出現超過兩年，標準; 否則👍 +50%或不保泌尿系統結石疾病	標準
	雙邊結石				多次發病: 最後徵狀出現超過五年，標準; 否則👍 +50%或不保泌尿系統結石疾病	
結石存在，偶發性發現，无症状、 肾功能正常、无血尿、无梗阻的临 床证据、未进行进一步临床检查或者 无治疗计划	單邊結石	按結石不存在評點			+50%或 不保泌尿系統結石疾病👍	標準
	雙邊結石				不保泌尿系統 結石疾病	人壽保障: 按結石不存 在評點 原位癌及癌症保障: 標準

備注: **最後決定視乎復發的次數及最後徵狀出現日期



靈活核保決定

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

核保指引

		人壽	危疾	早期危疾	住院	AIA 唯一摺保 (AOACS)
結石存在，存在腰/側腹痛或腹痛、 仅轻微或轻度血尿，无血压或肾功能异常	單邊結石	標準	+50%		+50%或 不保泌尿系統結石疾病 	標準
	雙邊結石	+50%	+100%及不保次級嚴重腎臟疾病		不保泌尿系統 結石疾病	人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: 標準

備注: **最後決定視乎復發的次數及最後徵狀出現日期



靈活核保決定

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

類風濕關節炎

簡介：是一種免疫系統炎性疾病，主要影響關節及其周圍組織

徵狀：疲勞等全身徵狀；關節疼痛；關節外疾病和腫脹

成因

- 成因不明，但和基因與環境因素有關

治療

- 藥物治療
- 物理治療
- 情況嚴重可能需要做手術

風險分類

風險因素	輕度	中度	嚴重
疼痛的程度	輕微的疼痛和僵硬	疼痛和僵硬	持續疼痛
關節畸形	沒有關節畸形	輕微的關節畸形	中度或明顯的關節畸形
治療反應	無需持續治療	頻繁和持續的藥物治療	對治療反應差

核保要求

- 體驗
- 驗血 -類別 Y : RA Factor 及 ESR
- 主診醫生報告

類風濕關節炎



核保指引

僅適合成人使用

風險分類		人壽 / 癌症全方位		危疾 / 早期危疾	
		年齡≤55；及患病≤10年	其他情況	年齡≤55；及患病≤10年	其他情況
沒有有關節外病變表現	輕度	標準	+50%	標準	標準
	中度	+50%	+75%	+50%；及不保類風濕關節炎及完全及永久傷殘	+75%；及不保類風濕關節炎及完全及永久傷殘
	嚴重	+100%	人壽：+150% 癌症全方位：拒絕受保	+100%；及不保類風濕關節炎及完全及永久傷殘	+150%；及不保類風濕關節炎及完全及永久傷殘
其他情況		個別考慮			

備註：最後決定取決於年齡、病史長短、關節外病變之程度、心血管風險因素和治療類型

AIA confidential and proprietary information. Not for distribution.

[AIA – INTERNAL]

類風濕關節炎



核保指引

僅適合成人使用:

風險分類		AIA 唯一摯保 (AOACS)				
		Age ≤ 55, 及患病為期:			Age ≥ 56, 及患病為期:	
		≤1 年	超過 1 年但少於 10 年	超過 10 年	≤ 1 年	超過 1 年
沒有關節外病變表現	輕度	人壽保障:標準 原位癌及癌症保障: +100%	人壽保障:標準 原位癌及癌症保障: +50%	人壽保障:+50% 原位癌及癌症保障: +50%	人壽保障:+50% 原位癌及癌症保障: +100%	人壽保障:+50% 原位癌及癌症保障: +50%
	中度	人壽保障:+50% 原位癌及癌症保障: +100%	人壽保障:+50% 原位癌及癌症保障: +50%	人壽保障:+75% 原位癌及癌症保障: +50%	人壽保障:+75% 原位癌及癌症保障: +100%	人壽保障:+75% 原位癌及癌症保障: +50%
	嚴重	人壽保障:+100% 原位癌及癌症保障: +100%	人壽保障:+100% 原位癌及癌症保障: +50%	拒絕受保		
其他情況		個別考慮				

備註：最後決定取決於年齡、病史長短、關節外病變之程度、心血管風險因素和治療類型

類風濕關節炎



核保指引

僅適合成人使用

風險分類	住院
輕度	不保類風濕關節炎和任何關於關節和關節外病變表現的疾病或病症
其他	拒絕受保

脊椎彎曲

簡介：創傷性脊椎神經損傷；退化

徵狀：脊椎活動受限制導致只能做有限度伸展或延伸；運動 / 感覺
神經癱瘓或有伴隨括約肌功能障礙

位置：背部；頸部

脊椎彎曲



成因

- 創傷；扭傷；變形；韌帶撕裂；骨折；病變；先天性因素

治療

- 鎮痛藥物治療；手術；物理治療

風險分類

輕度	步態正常，輕微的外觀變形，無內臟器官功能受損，肺功能化驗無異常
中度	更為明顯的變形，活動部分受限，但機體功能基本正常，無內臟器官功能受損, 肺功能化驗正常
嚴重	步態受損，明顯的變形，並發心肺功能受損，肺功能化驗異常（表明限制性肺功能障礙）

核保要求

- 如曾接受檢查，須遞交所有報告 (包括 X 光、磁力共振、電腦掃描等)
- 進行脊椎 X 光檢驗 (頸椎、胸椎、腰椎及 / 或腰骶尾椎)
- 詳述健康狀況：受傷日期；那一部分脊椎受影響；療程持續時間；曾接受的治療；和目前狀況

* 上表之核保指引是假設無神經疾病症狀或胸廓變形或無需接受任何治療

脊椎彎曲



核保指引 僅適合成人使用:

		人壽/癌症全方位	危疾/早期危疾	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
未接受手術	輕度胸廓變形	標準			
	中度胸廓變形	標準	標準	不保脊柱彎曲和任何呼吸、心臟或神經系統並發症	標準
	嚴重胸廓變形	至少+50%，取決於失能的程度和/或併發症的性質	+100%	拒絕受保	人壽保障: 至少+50%，取決於失能的程度和/或併發症的性質
	有心肺併發症	至少+50%，取決於失能的程度和/或併發症的性質	拒絕受保	拒絕受保	原位癌及癌症保障: 標準
已接受手術並痊癒，無後遺症（例如:呼吸困難，活動能力受阻等）	接受手術少於或等於一年	+50%	擱置受保	擱置受保	人壽保障: +50% 原位癌及癌症保障: 標準
	接受手術多於一年但少於五年	標準	標準	不保脊柱彎曲和任何呼吸、心臟或神經系統並發症	標準
	接受手術多於五年			標準	
有後遺症（例如:呼吸困難，活動能力受阻等）		個別考慮	拒絕受保	拒絕受保	個別考慮

地中海貧血

簡介：血紅蛋白減少及較小的紅血球，可分為 α 地中海貧血或 β 地中海貧血

成因

- 紅血球中的血紅蛋白製造不足；是一種遺傳性的血液疾病

地中海貧血類型

α 地中海貧血

- 隱性 α 地中海貧血：只有輕微貧血及平均壽命正常
- 血紅蛋白 H 病：嚴重程度視乎貧血程度、有否切除脾臟

β 地中海貧血

- 輕型 β 地中海貧血：無須接受治療及平均壽命正常
- 重型 β 地中海貧血：預後較差，需接受輸血及切除脾臟。例如庫利氏貧血

風險分類

隱性 α 地中海貧血 / 血紅蛋白 H 病 / 輕型 β 地中海貧血	
輕度	血紅蛋白 > 9.0 g/dl 無須接受輸血 無或輕度肝或脾臟腫大
中度	血紅蛋白 > 8.0 g/dl 偶爾需接受輸血 輕度肝或脾臟腫大
嚴重	血紅蛋白 ≤ 8.0 g/dl 需定期接受輸血 中度或嚴重肝或脾臟腫大

核保要求

- 驗血 (類別L), 如有須要
- 主診醫生報告 (視乎地中海貧血的類型)
- 需要詳述是否曾經輸血

地中海貧血



核保指引 僅適合成人使用:

	人壽	AIA 唯一摯保 (AOACS)	危疾 / 早期危疾 / 癌症全方位	住院
α 地中海貧血				
- 隱性或輕度 Hb* $\geq$ 10.0 g/dl	標準			
- 血紅蛋白H病 沒有溶血或輸血，穩定的血紅蛋白	個別考慮，+200%以上	拒絕受保	個別考慮，+100%以上	個別考慮
其他個案	個別考慮		拒絕受保	拒絕受保
β型地中海貧血				
- 輕度 Hb* $\geq$ 10.0 g/dl	標準			
- 中度 沒有溶血或輸血，穩定的血紅蛋白	個別考慮，+150%以上	拒絕受保	個別考慮，+100%以上	個別考慮
其他個案	個別考慮		拒絕受保	拒絕受保
- 重度	拒絕受保			
- 已做脾臟切除手術	個別考慮		拒絕受保	拒絕受保

* 備註：血紅蛋白

甲狀腺疾病

甲狀腺功能亢進症

簡介：甲狀腺荷爾蒙過高，導致身體處於高代謝狀態

徵狀：體重下降；食慾大增；焦慮；手震；心悸；怕熱；排汗增多；全身疲勞；排便次數增加及月經失調

位置：頸部(甲狀腺)

甲狀腺疾病

甲狀腺功能減退症

簡介：甲狀腺荷爾蒙過低，導致身體處於低代謝狀態

徵狀：虛弱；疲勞；畏寒；體重增加；抑鬱；頭髮脆弱；乾性 / 片狀皮膚；黏液水腫 (非凹陷性水腫)；面 / 手 / 足腫脹；聲音嘶啞及月經失調

位置：頸部 (甲狀腺)

甲狀腺功能亢進症 / 甲狀腺功能減退症



成因

- 甲狀腺功能亢進症：自體免疫失調；甲狀腺發炎；甲狀腺腫瘤；腦下垂體腺病
- 甲狀腺功能減退症：甲狀腺無法製造 **T3** 及 **T4**；曾做甲狀腺切除手術 (部分或全部)；曾接受放射性碘治療甲亢；頸部曾接觸輻射；X 光造影劑及藥物影響

治療

- 藥物；放射性碘 / 甲狀腺素替代劑；手術切除

甲狀腺功能亢進症 / 甲狀腺功能減退症



核保要求

- 驗血 (類別O)

核保指引

		人壽	危疾 / 早期危疾 / 癌症全方位	住院	AIA 唯一摯保 (AOACS)
甲狀腺功能亢進症	目前正在檢查中 或沒有足夠治療及病情未受控制	自完成檢查及情況穩定起計三個月內 擱置受保			擱置受保
	病情受控制 (無徵狀, 病情受控制, 甲狀腺功能正常, 無並發症, 無復發)	標準	標準	若停止治療超過兩年: 標準 否則, +100% 或不保甲狀腺 	標準
甲狀腺功能減退症	先天性甲狀腺功能減退症或兒童甲狀腺功能減退症	個別考慮			
	不受控制的高血壓 或 心血管異常	個別考慮	個別考慮	拒絕受保	人壽保障: 個別考慮 原位癌及癌症保障: 標準
	有足夠的治療及病情受控制 沒有高血壓 或 心血管異常	標準	標準	若診斷超過兩年: 標準 否則不保甲狀腺	標準

備註:  靈活核保決定

甲狀腺疾病

甲狀腺結節

簡介：甲狀腺結節是不正常過度生長的甲狀腺組織

徵狀：大多數情況下不會引起症狀；有時結節中的組織會產生過多的三碘甲腺原氨酸（**T3**）和四碘甲腺原氨酸（**T4**）

成因

- 缺乏碘；甲狀腺組織過度生長；甲狀腺慢性炎症

並發症

- 吞嚥和呼吸問題
- 甲狀腺功能亢進症

治療

- 甲狀腺激素抑制療法
- 手術切除

核保要求

- 驗血(類別O)
- 最近六個月內之甲狀腺超聲波報告
- 病理報告 (如已做切除手術)

核保指引

		人壽	危疾 / 早期危疾	住院	癌症全方位	AIA 唯一摺保 (AOACS)
現有甲狀腺結節	診斷未確定，惡性未排除	擱置受保至全面檢測				
	實性結節，無可疑超聲波特徵，惡性排除 (需遞交甲狀腺超聲波報告及驗血(類別O)結果正常)	標準	不保早期甲狀腺癌及/或甲狀腺癌	不保甲狀腺	不保甲狀腺癌	人壽保障: 標準 原位癌及癌症保障: 不保早期甲狀腺癌及/或甲狀腺癌
手術切除/活檢診斷 (需遞交病理報告證明)	良性腺瘤	標準				
	否則	個別考慮*				

備註：

* 最終決定視乎病理報告及驗血(類別O)的結果

乳房超聲波報告的首選化驗所

快驗保香港有限公司	MediFast Hong Kong Limited
精確X光醫學化驗所	EXACT Medical Laboratory & X-Ray Services
香港專科	The Specialists
毅寶診斷中心	Able Body Check and Diagnostic Centre
聖保祿醫院	St Paul's Hospital
冠天醫學診斷及化驗中心	Hercules Medical Diagnostic Centre
卓健醫療體檢中心	Quality HealthCare Medical Centre
標準病理檢驗所有限公司	PHC Medical Diagnostic Centre Limited
新康X光化驗中心有限公司	New Health X-Ray and Laboratory Centre Limited
嘉恩醫學化驗所X光室有限公司	The Giant Medical Laboratory and X-ray Services Limited
香港體檢	HKHC
宏康醫學診斷中心	Central Medical Diagnostic Centre
美邦醫學體檢中心有限公司	Mobile Medical and Health Check Centre Limited
雅博醫學診斷及化驗中心	Alpha Medical Diagnostic & Laboratory Center
信心X光醫學化驗中心有限公司	Dynamic X-ray & Medical Laboratory Ltd.
亞洲醫學診斷中心	Asian Medical Diagnostic Centre
香港仁安醫院	Hong Kong Union Hospital
--	Dr. Roentgen & Partners Medical Imaging Limited
香港婦女影像診斷中心	Hong Kong Women's Imaging

盆腔超聲波報告的首選化驗所

標準病理檢驗所有限公司	PHC Medical Diagnostic Centre Limited
香港浸信會醫院	Hong Kong Baptist Hospital
嘉恩醫學化驗所X光室有限公司	The Giant Medical Laboratory and X-ray Services Limited
博安醫學檢驗中心	Promed Diagnostic Centre Ltd
精確X光醫學化驗所	EXACT Medical Laboratory & X-Ray Services
雅博醫學診斷及化驗中心	Alpha Medical Diagnostic & Laboratory Center
科大醫院	University Hospital (Macau)

前列腺超聲波報告的首選化驗所

香港聖德肋撒醫院

Hong Kong St Teresa's Hospital

香港聖保祿醫院

Hong Kong St. Paul Hospital

香港養和醫院

Hong Kong Sanatorium & Hospital

驗血類別



	Component	檢驗項目	检验项目
驗血類別 A*	Complete Blood Picture (CBP) HBsAg ALT AST Gamma-GT Albumin Alkaline-phosphatase Creatinine Uric Acid Urea Total Cholesterol HDL-Cholesterol Triglyceride Fasting Blood Sugar HIV	全血像 乙型肝炎表面抗原 谷丙轉氨酶 谷草轉氨酶 丙種谷氨酸轉肽酶 白蛋白 鹼性磷酸酶 肌酸酐 尿酸 尿素 總膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 三酸甘油脂 空腹血糖 愛滋病抗原及抗體測試	血常规 乙肝病毒表面抗原 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 γ-谷氨酰转移酶 白蛋白 碱性磷酸酶 肌酐 尿酸 尿素 总胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇 甘油三酯 空腹血糖 艾滋病抗原及抗体测试
驗血類別 B	Creatinine Urea	肌酸酐 尿素	肌酐 尿素
驗血類別 D	ALT AST Gamma-GT Alkaline-phosphatase Albumin	谷丙轉氨酶 谷草轉氨酶 丙種谷氨酸轉肽酶 鹼性磷酸酶 白蛋白	丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 γ-谷氨酰转移酶 碱性磷酸酶 白蛋白

*Fasting for 6 hours (6小時前禁食)

驗血類別



	Component	檢驗項目	检验项目
驗血類別 E	Albumin Globulin Bilirubin	白蛋白 球蛋白 總膽紅素	白蛋白 球蛋白 总胆红素
驗血類別 F	HBsAg ALT AST Alkaline-phosphatase Albumin	乙型肝炎表面抗原 谷丙轉氨酶 谷草轉氨酶 鹼性磷酸酶 白蛋白	乙肝病毒表面抗原 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 碱性磷酸酶 白蛋白
驗血類別 G	A-FetoProtein	甲種胚胎蛋白	甲胎蛋白
驗血類別 H	HIV	愛滋病抗原及抗體測試	艾滋病抗原及抗体测试
驗血類別 I*	Gamma-GT Complete Blood Picture (CBP) Uric Acid Triglyceride	丙種谷氨酸轉肽酶 全血像 尿酸 三酸甘油脂	γ-谷氨酰转移酶 血常规 尿酸 甘油三酯
驗血類別 J	HBeAg ALT AST Alkaline-phosphatase Albumin	乙型肝炎E抗原 谷丙轉氨酶 谷草轉氨酶 鹼性磷酸酶 白蛋白	乙肝病毒E抗原 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 碱性磷酸酶 白蛋白

*Fasting for 6 hours (6小時前禁食)

驗血類別



	Component	檢驗項目	检验项目
驗血類別 K	Creatinine Urea Sodium Potassium Chloride Bicarbonate Calcium Phosphate	肌酸酐 尿素 鈉 鉀 氯化物 重碳酸鹽 鈣 磷酸鹽	肌酐 尿素 钠 钾 氯 碳酸氢盐 钙 血磷
驗血類別 L	Complete Blood Picture (CBP)	全血像	血常规
驗血類別 M*	Cholesterol HDL-Cholesterol Triglycerides	總膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 三酸甘油脂	总胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇 甘油三酯
驗血類別 N*	Fasting Blood Sugar HbA1c	空腹血糖 糖化血色素	空腹血糖 糖化血红蛋白
驗血類別 O	Free T4	甲狀腺素	甲状腺素

*Fasting for 6 hours (6小時前禁食)

驗血類別



	Component	檢驗項目	检验项目
驗血類別 P*	Total Cholesterol HDL-Cholesterol Fasting Blood Sugar ALT AST Gamma-GT HBsAg Creatinine	總膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 空腹血糖 谷丙轉氨酶 谷草轉氨酶 丙種谷氨酸轉肽酶 乙型肝炎表面抗原 肌酸酐	总胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇 空腹血糖 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 γ-谷氨酰转移酶 乙肝病毒表面抗原 肌酐

*Fasting for 6 hours (6小時前禁食)

驗血類別



	Component	檢驗項目	检验项目
驗血類別 R*	Complete Blood Picture (CBP)	全血像	血常规
	ALT	谷丙轉氨酶	丙氨酸氨基转移酶
	AST	谷草轉氨酶	天门冬氨酸氨基转移酶
	Gamma-GT	丙種谷氨酸轉肽酶	γ-谷氨酰转移酶
	Alkaline-phosphatase	鹼性磷酸酶	碱性磷酸酶
	HBsAg	乙型肝炎表面抗原	乙肝病毒表面抗原
	Total Cholesterol	總膽固醇	总胆固醇
	HDL-Cholesterol	高密度脂蛋白膽固醇	高密度脂蛋白胆固醇
	LDL-Cholesterol	低密度脂蛋白膽固醇	低密度脂蛋白胆固醇
	LDH	乳酸脱氢酶	乳酸脱氢酶
	Triglycerides	三酸甘油脂	甘油三酯
	Fasting Blood Sugar	空腹血糖	空腹血糖
	HbA1c	糖化血色素	糖化血红蛋白
	Uric Acid	尿酸	尿酸
	Urea	尿素	尿素
	Creatinine	肌酸酐	肌酐
	HIV	愛滋病抗原及抗體測試	艾滋病抗原及抗体测试
驗血類別 Y	Others (to be specified)	其他 (請註明)	其他 (请注明)

*Fasting for 6 hours (6小時前禁食)

1. 血液問題

English	香港常用名稱	国内常用名称
Anaemia	貧血	贫血
Iron deficiency anaemia	缺鐵性貧血	缺铁性贫血
Thalassaemia	地中海貧血	地中海贫血
Hypercholesterolaemia	高膽固醇血症	高胆固醇血症
Hypertriglyceridaemia	高三酸甘油脂血症	高甘油三酯血症

2. 乳房疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Breast cyst	乳房囊腫	乳腺囊肿
Breast fibroadenoma	乳房纖維瘤	乳腺纤维瘤
Breast mammary gland hyperplasia	乳腺增生	乳腺增生
Breast lobular hyperplasia	乳房小葉增生	乳腺小叶增生

3. 腦血管疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Stroke	中風	中风
Transient Ischameic Attack (TIA)	短暫性腦缺血發作	短暂性脑缺血发作

4. 消化系統疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Neonatal jaundice	新生兒黃疸	新生儿黄疸
Gastritis	胃炎	胃炎
Peptic ulcer	消化性潰瘍	消化性溃疡
Duodenal ulcer	十二指腸潰瘍	十二指肠溃疡
Hepatitis A	甲型肝炎	甲型肝炎
Hepatitis B	乙型肝炎	乙型肝炎
Fatty liver	脂肪肝	脂肪肝
Liver haemangioma	肝血管瘤	肝血管瘤
Gastro-oesophageal reflux	胃食道反流	胃食道反流病
Hemorrhoids	痔瘡	痔疮
Colon polyp	腸息肉	肠息肉
Gallstone	膽石	胆囊结石
Gallbladder polyp	膽囊息肉	胆囊息肉
Anal fistula	肛瘻	肛瘻

5. 耳鼻喉疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Sinusitis	鼻竇炎	鼻窦炎
Otitis media	中耳炎	中耳炎

6. 眼科疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Cataract	白內障	白内障
Retinal detachment	視網膜脫落	视网膜脱离
Glaucoma	青光眼	青光眼

7. 生殖器官疾病 - 女性

English	香港常用名稱	国内常用名称
Vaginitis	陰道炎	阴道炎
Ovarian cyst	卵巢囊腫	卵巢囊肿
Uterine fibroid	子宮肌瘤	子宫肌瘤
Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN)	子宮頸上皮細胞瘤樣增生	宫颈上皮细胞瘤样增生
Endometriosis	子宮內膜異位	子宫内膜异位症
Polycystic Ovarian Syndrome	多囊卵巢症	多囊卵巢综合征

8. 生殖器官疾病 - 男性

English	香港常用名稱	国内常用名称
Prostatitis	前列腺炎	前列腺炎
Benign prostatic hyperplasia	良性前列腺增生	前列腺增生

9. 心臟疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Hypertension	高血壓	高血压
Coronary Artery Disease (CAD)	冠狀動脈性心臟病 (冠心病)	冠心病
Atrial Septal Defect (ASD)	心房間隔缺損	房间隔缺损
Ventricular Septal Defect (VSD)	心室間隔缺損	心室间隔缺损
Mitral valve prolapse	二尖瓣脫垂	二尖瓣关闭不全
Mitral regurgitation	二尖瓣倒流	二尖瓣反流
Tricuspid regurgitation	三尖瓣倒流	三尖瓣反流
Heart murmur	心雜音	心脏杂音

10. 精神病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Anxiety	焦慮症	焦虑症
Depression	抑鬱症	抑郁症

11. 新陳代謝或內分泌問題

English	香港常用名稱	國內常用名稱
Overweight	過重	超重
Diabetes Mellitus	糖尿病	糖尿病
Hyperprolactinaemia	高催乳素血症	高催乳素血症

12. 呼吸系統疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Asthma	哮喘	哮喘
Pneumonia	肺炎	肺炎
Obstructive Sleep Apnoea (OSA)	睡眠窒息症	阻塞性睡眠呼吸暂停
Bronchitis	支氣管炎	支气管炎

13. 骨骼疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Degenerative change of spine	脊椎退化	脊椎退行性改变
Prolapsed intervertebral disc	脊椎間盤突出	脊间盆突出

14. 皮膚疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Eczema	異位性皮膚炎 (濕疹)	异位性皮肤炎
Psoriasis	牛皮癬	牛皮癣 (寻常型银屑病)

15. 甲狀腺疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Hyperthyroidism	甲狀腺功能亢進症 (甲狀腺素高)	甲状腺功能亢进症 (甲亢)
Hypothyroidism	甲狀腺功能減退症 (甲狀腺素低)	甲状腺功能减退症 (甲减)
Thyroid nodule	甲狀腺結節	甲状腺结节
Thyroiditis	甲狀腺炎	甲状腺炎

16. 泌尿系統疾病

English	香港常用名稱	国内常用名称
Haematuria	血尿症	血尿
Proteinuria	蛋白尿症	蛋白尿
Urinary tract infection	尿道炎	尿道炎
Nephritis	腎炎	肾炎
Renal Stone / Calculus	腎石	肾结石

常見檢查



English	香港常用名稱	国内常用名称
Medical Examination	體檢	体检
Micro-Urinalysis	顯微鏡尿液分析 (驗小便)	尿液分析
Cotinine	尼古丁測試	尼古丁测试
Resting Electrocardiogram	靜態心電圖	静态心电图
Treadmill	動態心電圖	运动心电图
Chest X-Ray	胸部X光	胸部x光
Ultrasound Thyroid Gland	甲狀腺超聲波	甲状腺彩超
Ultrasound Liver	肝臟超聲波	肝脏超声
Ultrasound Abdomen	腹部超聲波	腹部超声
Ultrasound Pelvis	盆腔超聲波	盆腔超声

常見檢查



English	香港常用名稱	国内常用名称
Ultrasound Breasts	乳房超聲波	乳腺彩超
Ultrasound prostate gland	前列腺超聲波	前列腺超声
Pulmonary Function Test	肺功能測試	肺功能测试
Computerized Tomography (CT Scan)	電腦斷層掃描	電腦斷層掃描 (CT)
Positron Emission Tomography (PET scan)	正電子掃描	正電子掃描 (PET)
Magnetic Resonance Imaging (MRI)	磁力共振	磁共振检查
Biopsy	活組織檢查	活组织检查 (活检)
Echocardiogram	心臟超聲波	多普勒超声 (超声心动图)
Gastroscopy	胃鏡	胃镜
Colonoscopy	腸鏡	肠镜

數位等級表



保費評級	額外保費率
MR A	+25%
MR B	+50%
MR C	+75%
MR D	+100%
MR E	+125%
MR F	+150%
MR H	+200%
MR J	+250%
MR L	+300%
MR N	+350%
MR P	+400%